

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ශ්‍රේෂ්ඨ පත්‍රය

අති විශේෂ

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை

அதி விசேஷமானது

අංක 2023/44 - 2017 ජුනි මස 15 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා - 2017.06.15
2023/44 ஆம் இலக்கம் - 2017 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம் 15 ஆந் திகதி வியாழக்கிழமை

(අරසාங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

பகுதி I : தொகுதி (I) - பொது

அரசாங்க அறிவித்தல்கள்

இலங்கையின் சுகாதார தேசிய தகவல் கொள்கை

இலங்கையின் சுகாதார தேசிய தகவல் கொள்கை அமைச்சரவை அங்கீகாரம் 2017 ஆம் ஆண்டு சனவரி மாதம் 3 ஆந் திகதியிலிருந்து நடைமுறைக்கு வரும் சுகாதார தகவல் முறைமைக்கான தேவையை இந்தக் கொள்கையும் தந்திரோபாய திட்டமும் நிறைவு செய்கின்றது. இது இலங்கையினுடைய வினைத்திறனானதும் நம்பிக்கையானதுமான சுகாதார சேவையின் பராமரிப்புச் சேவையை எட்டுவதற்கான செயல்முறையை மேற்கொள்ளும் தீர்மானத்திற்கு உதவியைச் செய்கின்றது. தேசிய சுகாதார கொள்கையின் நோக்கத்தை அடைவதற்கு இந்தக் கொள்கையும் தந்திரோபாய திட்டமும் ஒத்தாசை புரியும். இதனை நடைமுறைப்படுத்துவதன் ஊடாக நம்பிக்கையானதுமான வினைத்திறனானதுமான சம்பந்தப்பட்ட சுகாதார தகவல் முறைமை துறைகளுக்கு வழங்க முடியும்.

பீ. ஜி. எஸ். குணதிலக,

செயலாளர் (பதில்),

சுகாதார, போசாக்கு மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சு.

சுகாதார, போசாக்கு மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சு,
இல. 35, வண. பத்தேகம விமலவன்ச தேரோ மாவத்தை,
கொழும்பு 10,
2017, யூன் 15.

முன்னுரை

இலங்கையில் உள்ள அனைத்து நடைமுறையிலுள்ள அனைத்துச் சட்டங்களுக்கு அமைவாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் தேசிய சுகாதார தகவல் கொள்கை சுகாதார பராமரிப்பு வசதிகளை வழங்கும் நிறுவனங்களின் சுகாதார தகவல் முகாமைத்துவ மேம்பாட்டை எளிதாக்கும் என்பதுடன் சரியான செயல்பாடுகளை இலகுவாக்கி தகவல் முறைமை உள்ள இடைவெளிகளை அடையாளம் கண்டு வழிகாட்டிகளை வழங்குவதன் ஊடாக சுகாதார தகவல் தலைமுறை, வழங்கல், ஆய்வு மற்றும் பயன்பாட்டுக்குப் பொறுப்பான நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளைக் கண்காணிப்பதன் ஊடாக சுகாதார இலக்குகளுக்கு இணையாக ஒட்டுமொத்த சுகாதார மேம்பாட்டுக்கு இந்தக் கொள்கை பங்களிப்புச் செய்யும்.

இலங்கையின் சுகாதார தகவல் தேசிய கொள்கை - 2017

சுகாதார அமைச்சு

இலங்கை

இலங்கையின் சுகாதார தகவல்கள் தேசிய கொள்கைக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம்
2017, சனவரி 3 ஆந் திகதி கிடைக்கப்பெற்றது.



சுகாதார தகவல் மீதான தேசிய கொள்கை

சுகாதார போசாக்கு மற்றும் சுதேச மருத்துவ அமைச்சு

பின்னணி

சுகாதார தகவல்கள் எனப்படுபவை சுகாதாரம் அல்லது சுகாதார பராமரிப்பு சேவை சம்மந்தமான தரவுகள் அல்லது தகவல்கள் பெறப்பட்டு பரிமாறப்பட்டு செயன்முறைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு களஞ்சியப்படுத்தப்பட்டு பரப்பப்படும் காகித வடிவிலான அல்லது இலத்திரனியல் வடிவிலான தகவல் தொகுப்பாகும். அதாவது இச் சொற்பதம் நோய் வரும் முன் தடுப்பு, குணமாக்கும் (சிகிச்சை அளிக்கும்) சுகாதார சேவைகள், சுகாதார நிர்வாக சேவைகளும் ஆராய்ச்சிகளும் போன்றவற்றின் தரவுகள் அல்லது தகவல்களை கொண்டதாக அமையும் சுகாதார பராமரிப்பு சேவையானது சுகாதார தகவல்களை வளமாக அத்தியாவசியமாக கொண்டு இடம்பெறும் சேவையாகும். இத் தகவல்களை கொண்டு நோய் நிதானம் சிகிச்சை அளித்தலும் பராமரித்தலும் சிகிச்சையின் விளைவுகள் மதிப்பிடுதல் திட்டமிடுதல் கண்காணித்தல் போன்ற செயல்முறைகள் செய்யப்படுகின்றன. ஆகவே துல்லியமான நம்ப தகுந்த உரிய பொருத்தமான இலகுவாக அணுகத்தக்க நேரம் மற்றும் பணவிரயம் குறைந்த சுகாதார தகவல்களை வழங்கும் எங்கும் வியாபித்திருக்கும் ஒரு அமைப்பு முறையானது. சான்று அடிப்படையிலான தீர்மானங்களை மேற்கொள்ளும் சுகாதார சேவைகளுக்கு அத்தியாவசியமானது.

சுகாதார பராமரிப்புச் சேவைக்கான கேள்வி அதிகரிப்பு பராமரிப்புச் வேலைக்கான சம பங்கீட்டின் அவசியம் உயர்த்தத்திலான சுகாதார பராமரிப்பு சேவையின் கேள்வி அதிகரிப்பு என்பன சுகாதார தகவல் கட்டமைப்பினை சுகாதார கட்டமைப்பின் மிக முக்கிய அடிப்படை அலகாகக் கணிக்கப்படுகிறது.

இலங்கை அரசானது சர்வதேச தரத்திலான சுகாதார பராமரிப்பை வழங்குவதன் மூலம் மக்களை வரமுன் நோயில் இருந்து பாதுகாத்தல். நோய்க்கு சிகிச்சையை அளித்தல் போன்றவற்றில் சிறந்த சேவையை வழங்குகின்றது. பெரும்பாலான சுகாதார சேவைகள் மேற்கூறிய வைத்திய முறைமையாக இருப்பினும் சுதேச வைத்திய முறைமையும் இலங்கையின் சுகாதார தேவைகளை பூர்த்தி செய்கின்றது. மேலும் தனியார் சுகாதார சேவைகள் வழங்கும் நிறுவனங்கள் முக்கியமாக சிகிச்சை பராமரிப்பை வழங்கும் முறையில் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் வகையில் சேவைகளை வழங்கி வருகின்றது. இலங்கையின் தேசிய சுகாதாரத் தகவல் கட்டமைப்பானது ஒரு நூற்றாண்டு காலப்பகுதியினூடாக படிப்படியாக வளர்ந்து வந்ததும் பல தரப்பட்ட விசேட பிரிவுகள் அடிப்படையிலான தகவல்களை கொண்டமைந்தது.

இத் தகவல் கட்டமைப்பானது ஒவ்வொரு பிரிவுகளுக்கும் இடையே பின்னி பிணைந்த ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தொடர்புகளையுடையது. இச் சுகாதார தகவல் கட்டமைப்பானது இலங்கையினை உலகின் சிறந்த சுகாதார பராமரிப்பு சேவையினை செய்யும் நாடுகளின் வரிசையில் ஒன்றாக பேணுவதற்கு மிக சிறந்த பங்களிப்பினை வழங்குகின்றது.

(National health information system) தேசிய சுகாதார தகவல் கட்டமைப்பானது அரசு சுகாதார சேவையில் இருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. தற்போதைய சுகாதார தகவல் கட்டமைப்பானது குணமாக்கும் அல்லது சிகிச்சை அளிக்கும் (வைத்தியசாலை) தகவல் கட்டமைப்பு நோய்த்தடுப்பு பிரிவு தகவல் கட்டமைப்பு சனத்தொகை மதிப்பீடு பொது மக்கள் அத்தியாவசிய பதிவேடுகள் பொது சனங்கள் அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆராய்வறிக்கைகள் போன்ற உப கட்டமைப்புகளைக் கொண்டமைந்துள்ளது. இந்த உப கட்டமைப்புகள் இறப்பு நோய் தாக்கத்திற்குள்ளாதல், திடீர் தொற்று நோய் பரவல் சமூக சுகாதாரப் பழக்கவழக்கங்கள் (உதாரணமாக போசணை, வாய் சுகாதாரம்) சுகாதார வளர்ச்சி, பிறப்பு, திருமணங்கள் சுகாதாரச் சேவைகளைப் பெறும் வழிவகைகள் சுகாதார ஆளணி வளம், சேவையின் தரம் சுகாதாரத்திற்கான நிதி ஒதுக்கீடு போன்ற காரணிகளிலிருந்து தரவுகளைப் பெறுகின்றன.

(State Health Information System) அரசு சுகாதார தகவல் கட்டமைப்பானது சேவை வழங்கும் இடங்களில் இருந்து கையால் எழுதப்பட்டு ஆவணப்படுத்தப்பட்ட காகித வடிவத்தில் தரவுகளைப் பெற்று, இவை பிராந்திய அல்லது மத்திய நிலையங்களுக்கு பரிமாற்றப்படுகிறது. பின்பு பிராந்திய அல்லது மத்திய நிலையங்களுக்கு இத்தரவுகள் கணணிகள் மூலமும் உத்தியோகத்தர் மூலமும் பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது.

இவ்வாறு பெறப்பட்ட சுகாதாரத் தகவல்கள் தேசிய பிராந்திய நிறுவனங்களின் ஊடாகவும் வெளியீடுகள் விளம்பரங்கள் ஊடாகவும் பரப்பப்பட்டு வெளியிடப்படுகின்றது. மிக முக்கியமான தேசிய சுகாதார வெளியீடு இலங்கை வருடாந்த சுகாதார வெளியீட்டிற்கு என அழைக்கப்படுகின்றது. பெரும்பாலான வெளியீடுகள் காகித வடிவிலாவை தற்போது எல்லைபடுத்தப்பட்ட அளவில் சுகாதாரத் தகவல்கள் இலங்கை சுகாதார அமைச்சின் உத்தியோகபூர்வ வலைதளத்திலும் சுகாதார மற்றும் போசணை அமைச்சு, அமைச்சுகளின் கணணி வலைத்தளங்களிலும் கிடைக்கப்பெறுகின்றன.

அதே வேளை பெரியளவிலான தனியார் சுகாதார நிறுவனங்கள் தங்களிற்குரிய சுகாதார தகவல் கட்டமைப்பினை பேணுகின்றனர். பெரும்பாலான நடுத்தர அளவிலான சிறிய அளவிலான சுகாதார பராமரிப்பு நிறுவனங்கள் சுகாதார தகவல்களை பேணுவதில் ஆர்வமின்னையும் பணப் பற்றாக்குறைகளையும் கொண்டமைந்துள்ளன. இவ்வாறு பெரும்பாலான தனியார்

நிறுவனங்கள் நீர்ப்பீடனம் செய்தல், தொற்று நோய்களை அறிவித்தல், தாய் சேய் இறப்பு வீதம் தவிர்த்த ஏனைய விடயங்களை அரசு மட்டங்களுக்கு அறிக்கை விடுவதில்லை. மற்றும் சுகாதார ஊழியர்களின் சுகாதார தகவல்களைப் பெற வழக்கத்தில் ஒரு முறைமையும் பேணப்படவில்லை.

சுகாதார தகவல் கொள்கைக்கான அடிப்படை

2009ம் ஆண்டு ஓகஸ்ட் மாதம் சுகாதார மற்றும் சுதேச மருத்துவ அமைச்சினால் உலக சுகாதார நிறுவனத்தினால் தகவல்களை மதிப்பீடு செய்யப் பயன்படுத்தப்படும், சுகாதார தகவல்களை தொகுத்திருக்கும் Health Ministry Network வலையமைப்பு எனும் அளவு சுருவியை பயன்படுத்தி செய்த ஆய்வில் சில முக்கிய விடயங்கள் கவனத்திற்கு வந்தன. இதில் வளப்பற்றாகுறை முக்கிய விடயமாக வெளிவந்தது அதாவது கொள்கை உருவாக்கம் , திட்டமிடல் ,சுகாதார தகவல் கட்டமைப்பு, நிறுவனங்கள் , ஆளவியினர் நிதி , மற்றும் உட்கட்டமைப்பு என்பனவற்றின் வளப்பற்றாக்குறைகள் காணப்பட்டன. இத்தோடு தகவல்களை முகாமைத்துவம் செய்தலிலும் குறைப்பாடுகள் காணப்பட்டன.

தரவுகள் பெறப்படும் மூலகளங்களை உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தில் அளவீட்டு சுருவிகளை கொண்டு பகுப்பாய்வு செய்ததில் சனத்தொகையை அடிப்படையாக கொண்ட சுகாதார நோய் ஆய்வறிக்கை போதுமான மட்டத்திலிருப்பதும் ஆனால் சுகாதார சேவைகள் மற்றும் சுகாதார வளங்கள் பற்றி அறிக்கைகள் இப்போது இருப்பது போதுமான மட்டத்தில் இல்லை .என்பதும் வெளிச்சத்திற்கும் வந்தது. விரிவான சுகாதார தகவல் தொடர்பான பிரச்சனைகள் கொள்கை வகுப்பின் போது விபரிக்கப்படும்.

திருத்தியெடுக்கப்பட வேண்டிய பிரதான விடயங்கள்

இலங்கை தேசிய சுகாதார தகவல் கட்டமைப்புடன் தொடர்பான பிரதான பிரச்சனைகளாவன சுகாதார தகவல்களை முகாமைத்துவம் செய்வதில் தெளிவான கொள்கைகள் குறைவாகக் காணப்படல், தகவல் கையாளும் அதிகாரப் பொறிமுறையில் ஏற்பட்டுள்ள தொடர்ச்சியின்மை (தனித்தனியாக ஆக்கப்பட்டிருத்தல்) தற்போது நிலவும் தகவல் முறைகளுக்கிடையே ஒருங்கிணைப்பு காணப்படாமை, மட்டுப்படுத்தப்பட்ட தகவல் பரிமாற்றம், தீர்மானங்களை எடுக்கும்போது தகவல்களை நன்றாகப் பயன்படுத்தாமை, தொடர்ச்சியாக தகவல்களை தரவுப்படுத்தல் போதாமை என்பனவாகும். இவையாவும் நடுத்தர தரமுள்ள தகவல்களையே பெறக்கூடியதாய் இருப்பதற்கு காரணமாய் உள்ளது. அத்துடன் சுகாதார தகவல்கள் கட்டமைப்பானது மாறும் சுகாதாரத் தகவல் தேவைகளை ஈடு செய்யும் வகையில் தன்னை வளப்படுத்தவில்லை. இதனால் தற்போது மிகவும் எதிர்பாக்கப்படும் “தகவல் கலாச்சாரம்” எனும் அம்சம் சுகாதாரப் பகுதிக்குள் அடையப்பட முடியவில்லை.

பிராந்திய, நிறுவன ரீதியான அல்லது நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ரீதியாக தகவல் முகாமைத்துவத்தின் போது கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டிய பிரதான பகுதிகள் வரையறுக்கப்படவில்லை. சில நெறிமுறைகளை தங்களது தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மேற்கொண்டுள்ள போதும் அவர்கள் தேசிய சுகாதார தகவல் கட்டமைப்புடன் இடைத்தாக்கமுறுவதற்கு தொடர்புகளைப் பேணுவதற்கு உரிய முறைமை இல்லாததுள்ளது. சிறந்த முறையில் ஒன்றிணைந்து வேலை செய்ய முடியாதிருப்பதனால் பல்வேறு குழுக்கள் ஒரே தகவல்களையே திரும்பத் திரும்ப சேகரிக்கின்றனர். இதன் காரணமாக தகவல்களை நெறிப்படுத்தும்போது மேலதிக வேலைப்பழு ஏற்படுகின்றது. அத்துடன் அதிகமான தகவல்கள் காலத்திற்கேற்றவாறு மீள்மாற்றம் செய்யப்படுவதில்லை.

இலங்கையில் பொதுச்சுகாதார நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் இதற்கென நியமிக்கப்பட்ட இயக்குனர்களால் குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு சுதந்திரத்துடன் உருவாக்கி இயக்க முடிகின்றது. இவ்வாறே இவ்வியக்குனர்கள் சுதந்திரத்துடன் தகவல் கட்டமைப்புக்களையும் உருவாக்கி நடைமுறைப்படுத்துகின்றனர். இவை தகவல் பரிமாற்றத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்களவு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன.

மேலும் நடைமுறையில் உள்ள வைத்தியசாலை தகவல் முறைமையானது கடந்த 20 வருடங்களாக மீளாய்வு செய்யப்படவில்லை. ஆகையால் தற்போதைய தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக தகவல்களைப் பெற முடியாதுள்ளது. உதாரணமாக நடைமுறையில் உள்ள முறைமையில் வெளி நோயாளர் பிரிவில் விரிவான தகவல்களைப் பெறுவதில்லை. அத்துடன் அந்த நோயாளர்களின் சிகிச்சை தொடர்பான தொடர் பதிவுகளைப் பேணாமை என்பனவாகும், எனினும் சில தனியார் சுகாதார பராமரிப்பு நிறுவனங்கள் தங்களது தகவல்களை வழங்குவதற்கும் பகிர்வதற்கும் ஆர்வமாகவுள்ளனர். எனினும் தேசிய சுகாதார தகவல் முறையோடு ஒழுங்கமைத்து செயலாற்றுவதற்கு ஏற்ற பொறிமுறைகள் இல்லாததுள்ளது. அத்தோடு தேசிய சுகாதாரத் தகவல் கட்டமைப்பிற்கு தொழில்சார் சுகாதாரம் , சுற்றுப்புற சுகாதாரம் , காயங்கள் , சுதேச முறையிலான சிகிச்சையளிப்புகள், கண்காணிப்பும் மதிப்பாய்வும் சம்பந்தமான தரவுகள் மற்றும் வைத்தியசாலை நிர்வாகத் தகவல்கள் என்பவற்றுக்கு இடையே பாரிய தகவல் பரிமாற்ற இடைவெளி உண்டு.

மேலும் புவியியல் (தரைத்தோற்ற அமைப்பினை அடிப்படையாகக் கொண்டு) ரீதியாக சுகாதாரத்தையும் சுகாதார தகவல்களையும் தரவுப்படுத்தலுக்கு குறைந்த முக்கியத்துவமே கொடுக்கப்படுகின்றது. மருத்துவ ஆய்வு கூடங்கள், கதிரியக்க இயத்திரங்களில் இருந்து பெறப்படும் இலத்திரனியல் தகவல்கள் உரிய தகவல்கள் கட்டமைப்போடு சிறந்த முறையில் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.

நோய் தடுப்புச் சுகாதாரத்திலும் நோய் சிகிச்சையளிப்பு சுகாதாரத்திலும் இருந்து பெறப்பட்ட பெருவாரியான தகவல்கள் பெரும்பாலும் சாதாரண மக்கள் மட்டத்தில் இருந்து பெறப்பட்டவை. இருந்தும் பொதுவாக இருக்கும் போதியளவு தரவுகளை கொள்கை உருவாக்கலில் திட்டங்களை தயார்படுத்தலில் நிர்வாகத்திலும் சிகிச்சையளிப்பிலும் உரிய தீர்மானங்களை எடுப்பதிலும் பயன்படுத்துவதில்லை. இவ்வாறு உரிய காலத்திற்கு தகவல் பெற முடியாமல் இருப்பதற்கும் ஒப்பீட்டு ரீதியில் தகவல் பரிமாற்றத்தின் வேகம் குறைவாக இருப்பதற்கும், வேகமாக தகவல்களை தரவுபடுத்தி நெறிப்படுத்த முடியாதிப்பதற்கும், தரவுகளை வேகமாக பிரசுரிக் முடியாதுள்ளமைக்கும் முக்கிய காரணமாக அமைவன. இலகுவாக கிடைக்கக்கூடிய விதத்திலில்லாத கடதாசி வடிவிலான அறிக்கைகளும் புத்தகவேடுகளும் ஆகும். அத்தோடு “தகவல் சலாசாரக்” குறையீட்டிற்கான இன்னோர் காரணி சான்று முறையிலான தீர்மானங்கள் ஊக்கிவிக்கப்படுத்தலும் அத் தீர்மானங்களை மாதிரியாகவும் வழக்கமாகவும் சுருதுதலும் ஆகும்.

1989ம் ஆண்டு அதிகார பரவலாக்கலுக்குப் பின் சுகாதார சேவைகளுக்குப் பொறுப்பான நிறுவனமென மாகாண சுகாதார சேவைகள் திணைக்களம் மாகாணங்களில் இருந்தும் நோய்த்தடுப்புப் பிரிவிலிருந்தும், நோய் சிகிச்சையளிப்புப் பிரிவிலிருந்தும் போதியளவு விரிவான தகவல்களைப் பெறவில்லை. அத்தோடு மாகாண சுகாதார அமைச்சின் கீழுள்ள பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் திணைக்களம் தனக்கு கீழுள்ள நிறுவனங்களிடம் இருந்தே தகவல்களைப் பெறுகின்றன. ஆனால் இப்பிராந்தியத்தினுள் இருக்கும் மத்திய அரசால் நிர்வகிக்கப்படும் சுகாதார நிறுவனங்களில் இருந்து தரவுகளைப் பெறுவதில்லை. மத்திய அரசிற்குரிய சுகாதார நிறுவனங்கள் நேரடியாக மத்திய சுகாதார தகவல் மையத்திற்கே தகவல்களை வழங்கும். இதனால் ஏற்படும் தகவல் குறைபாடு மாகாண சுகாதார சேவைகள், பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் ஆதாரம் அடிப்படையில் முடிவெடுக்கும் தன்மையில் பாதிப்பை, தடையை ஏற்படுத்தும், ஒருவரை தனிப்பட்ட ரீதியாக இனங்காட்டக் கூடிய சுகாதார தகவல்கள் உயர் இரசகியத் தன்மை கொண்டதாக அமைய வேண்டும். தற்போது தகவல்களைக் கையாள்வதிலும், தகவல்களைப் பயன்படுத்துவதிலும், தகவல்களைப் பிரமிருவதிலும், தகவல்களை ஆய்வுகளுக்காக பயன்படுத்துவதிலும் போதியளவு சரியான நெறி முறைகள் பின்பற்றப்படவில்லை. தகவல் சம்பந்தமான பாதுகாப்பு நெறியானது காகித ரீதியில் உள்ள தகவல்களிலும் சரி கணணி ரீதியில் உள்ள தகவல்களிலும் சரி குறைவாகவே காணப்படுகின்றது.

சுகாதாரத் தகவல்களை கணனிமயப்படுத்தல் அல்லது இயந்திர மயப்படுத்தல் என்பது நம் நாட்டில் மிகவும் வேகம் குறைவாக நடைபெறுகிறது. அத்துடன் நிறுவனங்களுக்கிடையே ஒழுங்கிணைப்பும் குறைவாகவே காணப்படுகின்றது. அத்துடன் ஆரம்ப தகவல் தொடர்பாடு தொழில்நுட்ப சேவைகளுக்கான செலவுகளும் மிக அதிகமாக உள்ளது. தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பத்தினுள்ள சுகாதார ஊழியர்களின் அளவும் போதுமானதாக இல்லை. மேலும் திட்டமிட்டு செயலாற்றலை அதிகரித்தல், புதிய பணியாள் தொகுதியினை ஆட்சேர்த்தலும் புதிய பதவி வெற்றிடங்களை இனம் காணலும் (தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் முகாமைத்துவறையில்) போன்ற செயற்பாடுகள் மந்த கதியிலேயே உள்ளது.

சமகால முன்னேற்றங்கள்

கையெழுத்து வாடிவிலான காகித வாடிவிலான தேசிய சுகாதார தகவல் கட்டமைப்பு விரைவாக அருகி வருகின்றது. தேசிய சுகாதார தகவல் கட்டமைப்பை தற்காலத் தேவைகளுக்கு ஏற்றபடி நவீன மயப்படுத்த வேண்டியது அத்தியாவசியமானது. பாரம்பரிய காகித வாடிவிலான தகவல்களை பொருத்தமாகத் தெரிவு செய்த நீண்ட காலம் நிலைத்திருக்கும் செலவு குறைந்ததாக இருக்கக்கூடான தானியங்கி, சுண்ணி, இயந்திர மயமாக்கப்படல் வேண்டும்.

இலத்திரனியல் சுகாதாரம் (E-Health) தன்னியக்க முறைமையாக்கலும்
புதுமை புகுத்தலும்

உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் இலத்திரனியல் சுகாதாரத்தை பின்வருமாறு விபரிக்கின்றது.

“சுகாதார வளங்கள், சுகாதார பராமரிப்பு சேவையினை இலத்திரனியல் வழிமுறைகள் பயன்படுத்தும் படியாக மாற்றியமைத்தல்” பொதுவாக இலத்திரனியல் சுகாதாரம் என்பது தகவல் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான பிரயோகங்களை சுகாதாரத்தின் ஏதாவது அல்லது எல்லாப் பிரிவுகளிலும் பாவித்தலாகும்.

இலத்திரனியல் பிரயோகங்கள் பராமரிப்பு வழங்குதல் (நோயாளர் முகாமைத்துவம், சுகாதார சேவைகள் முகாமைத்துவம்) பொதுச்சுகாதாரம் (நோய்த்தடுப்பும் மேம்படுத்தலும்) மருத்துவக் கல்வி, சுகாதார ஆராய்ச்சிகள் என்பவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இலத்திரனியல் சுகாதாரம் முறைமையினை நடைமுறைப்படுத்துவதனால் ஏற்படுகின்ற அபரிமிதமான பயன்களை கருத்திற் கொண்டு இலங்கை அரசு சுகாதார துறையில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப பயன்பாட்டினை ஒருங்கிணைக்க இலங்கை அரசு சுகாதாரம் போசாக்கு மற்றும் சுதேச மருத்துவ அமைச்சு தேசிய இலத்திரனியல் சுகாதார வழிநடத்தும் குழுவை (NEHSC) இலத்திரனியல் சுகாதாரத்திற்கான அதிகாரம் பெற்ற தேசிய மட்டத்திலான அமைப்பு) இந்த ஆரம்ப முயற்சிக்கு உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் இலத்திரனியல் சுகாதாரத்திற்கான அடிப்படைக் கட்டமைப்பை இலத்திரனியல் சுகாதாரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு இயங்கும் நாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு தேசிய அடிப்படைச் செயற்பாடுகளை உருவாக்குதல்” எனும் தொனிப் பொருளுக்கு ஏற்றபடி செயற்படுத்த பெரும் ஒத்துழைப்பு வழங்கியது.

தேசிய இலத்திரனியல் சுகாதார வழிநடத்தும் குழுவின் வழிகாட்டலுக்கு கீழ் தேசிய இலத்திரனியல் சுகாதார வழிகாட்டியும் நியமங்களும் உருவாக்கப்பட்டது. (NEGS)

“ தேசிய சுகாதார தகவல் கட்டமைப்பின் கட்டடக் சபை அமைப்பு , மாதிரிகள் , தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகாமைத்துவம், தொடர்பாடல் வலையமைப்பும் , இணைப்பும் இடைத்தள தொடர்பு (வெவ்வேறு தொடர்பாடல் தொகுதிகளை இணைத்து தொடர்பாடல் மேற்கொள்ளல்) ஒழுங்கு நெறிகள், தனியுரிமை , தகவல் ரகசியத் தன்மை, தகவல்களினது பாதுகாப்பு, தரவுகளின் தராதரங்கள் என்பவற்றின் மீது இந்த வழிகாட்டிகள் உருவாக்கப்பட்டன. தற்போது சுகாதார இலாகாவின் எல்லாத் துறைகளுக்கும் இலத்திரனியல் சுகாதார ஆரம்ப வேலைத்திட்டங்களை தேசிய இலத்திரனியல் சுகாதார வழிகாட்டல்களும் நியமங்களும் வழிப்படுத்துகின்றது. (NEGS)

தற்கால E- சுகாதார தொடக்க வேலைத்திட்டங்கள் அல்லது முன்னெடுப்புக்கள்

அண்மைக்காலத்தில் சுகாதார தகவல் முகாமைத்துவம் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் காணப்படுகின்றது. சுகாதார போசாக்கு மற்றும் சதேச மருத்துவ அமைச்சு மருத்துவ பட்டப்படிப்பு நிறுவனமும் இணைந்து தனித்தன்மையான விசேட திறன் மிக்க ஆளணியினரை சுகாதார தகவல் முறைமைத்துவத்திற்காக உருவாக்கியுள்ளது. அதாவது அண்மைய புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு காரணமாக இருந்த உயர் மருத்துவ தகவல் செயன்முறையில் பயிற்சி பெற்ற வைத்தியர்களை இதற்காக நியமித்துள்ளது.

இவ் அபிவிருத்திக்கு மேலதிகமாக உள்நாட்டு இறப்பு மற்றும் ஆரோக்கியமற்ற தன்மைகள் பற்றிய அறிக்கைகள் அதன் காகித வடிவிலான தகவல்களுக்குப் பதிலாக பதிலீடு செய்யப்பட்டது. இவ்வாறு இறப்பு மற்றும் ஆரோக்கியமற்ற தன்மை புதிய தகவல்களின் தொகுப்பு இன்னும் மூன்று வருடங்களில் தன்னியக்கமாக்கப்படும். (Automated)

நடுத்தர அளவு வசதியுள்ள வைத்தியசாலைகள் பலவற்றில் இலத்திரனியல் வெளி நோயாளர் பிரிவு நோயாளர்களின் முகாமைத்துவ முறைமை பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகின்றது. அதே போன்று விடுதியில் தங்கி சிகிச்சை பெறும் நோயாளிக்கும் இவ்வாறான முறைமைகள் உருவாக்கப்பட்டு பரீட்சிக்கப்பட்டு வருகின்றது. தற்போதைய கவனம் முழு நோயாளிகளையும் அவர்களது நோய் நிதானத்தையும் (Diagnosis) பதிவு செய்தல் என்னும் நிலையில் உள்ளது. இந்தத் தகவல் கட்டமைப்புகள் தொடர்ந்து இருக்கத்தக்கதாக கணனி பராமரிப்பு பிரிவுகள் தெரிவு செய்யப்பட்ட வைத்தியசாலைகளின் விரிவாக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது பிறப்புகள் இலத்திரனியல் முறையில் பிள்ளைப்பேறு அறையில் இலத்திரனியல் வலையமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு நோய்த்தடுப்பு தகவல் மையத்தினூடாக (Web based immunization information system) பதியப்படுகின்றது. மற்றும் தாய் சேய் நலன் சுகாதாரமும் நோய்த்தடுப்பும் போன்ற துறையில் படிப்படியாக முன்னேற்றமாக அடிப்படைத் தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஒருவரினை அடையாளம் காண உதவும் (Personal Health Number)தனிநபர் சுகாதார இலக்கத்தினை நடைமுறைப்படுத்த பரீட்சார்த்த வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. இந்த இனம் காட்டி இலக்கமானது தொடர் பராமரிப்பிற்கும் வாழ்நாள் பூராக சுகாதாரப் பதிவுகளைப் பெறுவதற்கு வழிசெய்வதோடு தொடர்ச்சியாக சிகிச்சை பெறாதவர்களை இனம் காணவும் உதவும்.

மனித வளம் முகாமைத்துவ குழு (Human resources management - HRM) ஒன்று வைத்தியர்களுடைய சிக்கலான நியமங்கள் இடமாற்றங்கள் , பதவியேற்றங்கள் என்பவற்றைக் கையாண்டு தொழிற்பட்டுக்கொண்டுள்ளது. இதேபோன்றே மற்றைய ஊழியர்களின் விடயங்களையும் கையாளும் முறைமை சில மாற்றங்களோடு நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது.

இதே போன்று மருத்துவ விநியோகப் பிரிவு (Medical Supplies Division) ஆனது மருத்துவ விநியோகப் பொருட்களை மத்திய அமைச்சினூடாக பிராந்திய மாகாண அமைச்சுகளுக்கும் அங்கிருந்து வைத்திய நிறுவனங்களுக்கும் விநியோகம் செய்வதற்குமான ஒரு முறைமையை நடைமுறைப்படுத்தி உள்ளது.

இக்கொள்கை பற்றி

சுகாதார தகவல் மீதான தேசிய கொள்கை தேசிய சுகாதார கொள்கையுடன் இணைந்து செல்வதுடன் அக்கொள்கைக்கு ஆதரவாகவும் செயன்முறைப்படுத்தப்படுகின்றது. இக் கொள்கையை வகுக்கும் முயற்சி சுகாதாரத் தகவல்கள் முறைமையினை நவீன மயப்படுத்தல் குழுவின் அதிகாரிகளினால் காலத்தின் தேவை அறிந்து தகவல்கள் தொடர்பான பிரச்சினைகளை இனம் கண்டு அதில் இருந்து வெளிவருவதற்கும் அதனூடு தேசிய சுகாதாரக் கொள்கைகளை அடைவதற்குமாக முன்னெடுக்கப்பட்டது. அத்துடன் இக்கொள்கை பொருத்தமான சுகாதார தகவல் முறைமையின் பிரிவுகளை இலத்திரனியல் தகவல் முறைமையாக எதிர்காலத்தில் படிப்படியாக மாற்றுவதற்கு திட்டங்களையும் வழிமுறைகளையும் வகுத்துள்ளதோடு அதில் மாற்றங்கள் திருத்தங்களை ஊக்குவிக்கின்றது. நம்பகமான நல்ல தரம் வாய்ந்த தகவல்களை நெகிழ்ச்சியுள்ள சுகாதார தகவல் முறைமையினூடாக மேம்படுத்தப்பட்ட சுகாதார சேவையின் செயலாற்றல், தரமான சுகாதார பராமரிப்பு சேவை, எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியான சேவை கிடைக்கும் சந்தர்ப்பம் வழிமுறைகளும் , அதிகரித்த சேவை விநியோகம், சுமையைக் குறைத்தல் , வினைத்திறன் அதிகரிப்பு , குறைக்கப்பட்ட பண விரயம்

என்பன பெறப்படும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இக்கொள்கையானது முன்னரே அறிவிக்கப்பட்ட தெரியப்பட்ட தீர்மானம் எடுக்கும் செயன்முறையை சேவை வழங்குனருக்கும் சேவை பெறுனருக்குமாக இலகுபடுத்தும்.

கொள்கை உருவாக்கச் செயன்முறை

WHO சுகாதார தகவல்களை தொகுத்திருக்கும் வலையமைப்பின் (Health matrix network) அளவீட்டு ஆய்வறிக்கைக் கொள்கை உருவாக்கத்தின் ஆரம்ப கட்டத்தில் சிறந்த உதவியாய் இருந்து வழிநடத்தியது கொள்கை உருவாக்கல் செய்முறையானது தொடர்ச்சு தீவிர ஆர்வத்தைக் காட்டும் குழுக்களிடையே (இக்குழுக்களின் முக்கிய சுகாதார தகவல் 20- கட்டமைப்புகளின் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவனவாக இருந்தன) தீவிர அதிக ஆளமான தொடரான பகுப்பாய்வுகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது. கலந்துரையாடல்கள் ஆவணி 2012 தொடக்கம் மாசி 2013 வரை நடத்தப்பட்டது. பகுப்பாய்வு செய்தவர்கள் சுகாதாரத் தகவல் பிரிவைச் சேர்ந்தவர்களாகவும் (Health Information Unit) கொள்கைப் பிரிவைச் சேர்ந்தவர்களாகவும் (Policy Development and analysis) இருந்தனர். இவ் ஆரம்ப கொள்கை வரைவானது (Draft) சுகாதார போசணை மற்றும் சுதேச மருத்துவ அமைச்சிலுள்ள உயர்நிலை அதிகாரிகளினாலும் , புள்ளி விபரவியல் தொகை மதிப்பீட்டு திணைக்களத்தினாலும் (Department of census and statistics) பதிவாளர் நாயகத்தின் திணைக்களத்தினாலும் (Register General Department) உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தினாலும், உலக வங்கி மற்றும் ஏனைய நிதி உதவி செய்யும் நிறுவனங்கள், அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களினாலும் விரிவாகக் கலந்துரையாடப்பட்டது. இறுதிக்கொள்கைப் பதிவானது பொது மக்களால் நுணுகி ஆராயப்பட்டு அதன் மூலம் பெரும்பான்மையானவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒரு நிலைக்கு வந்த பின்பு அமைச்சரவை அங்கீகாரத்திற்கு விடப்பட்டது.

வழிகாட்டல் கோட்பாடுகள்

சுகாதார தகவல் கொள்கை பின்வரும் வழிகாட்டல் கோட்பாடுகளுக்கு அமைவாக இணைந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

1. குடிமக்களை மையப்படுத்திய அணு முறை
2. நல்ல பரிபாலனமும் வெளிப்படைத்தன்மை உடையதாய் இருத்தல்.
3. இலவச சுகாதார சேவையின் தேசிய பெறுமதியை, சுகாதார வசதி பெறுதற்கான உரிமையை, எல்லோருக்கும் சுகாதார சேவை கிடைத்தல், சமத்துவம் மற்றும் சமூக நீதி என்பவற்றை நிலைநாட்டல்.
4. அதிகமான ஈடுபாடு உடையவர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்தல், தகவல்களைப் பகிர்வதற்கும் விநியோகிப்பதற்குமாக ஒத்துழைத்து வேலை செய்தலும் கூட்டாயுமிருத்தல்.
5. ஆதாரத்தை மையப்படுத்திய முடிவெடுத்தல் அல்லது தீர்மானங்களை மேற்கொள்ளலும் பொறுப்புக் கூறலும்.
6. சுகாதாரப் பராமரிப்பு பெறுபவரின் விருப்பத்திற்கு ஏற்றபடி தனியுரிமை பேணும் தன்மை (Privacy), அவரின் ரகசியத் தன்மை என்பவற்றை பாதுகாத்தல்.
7. Cultural Diversity கலாச்சாரப்பன்முகத்தன்மை, சமூக நெறிகள் (Social norms) என்பவற்றில் அதிக உணர்திறன் (Sensitivity) மிக்கதாய் இருந்து அவற்றிற்கு மதிப்பளித்தல்.
8. சுகாதாரத் தகவல்களின் முழுக்கட்டமைப்பையும் அணுகக் கூடியவாறு (System approach) ஒன்றாய் இணைந்து வேலை செய்தல்.
9. தகவல் பெறுகையில் தேவையில்லாதவற்றையும் ஒரே தகவல்களை மீண்டும் பெறுதலையும் குறைத்தல்.
10. பொருத்தமான தொழில்நுட்பத் தெரிவு , எளிமைத்தன்மை, பணவிரயம் குறைந்த திறமையுள்ள சாதாரியமான வினைத்திறன் மிக்க தகவல் வளப்பாவணையை உறுதி செய்தல்.
11. தகவல் கட்டமைப்பின் தொடர்ந்து நீடித்து நிலை பெறும் தன்மையை உறுதி செய்தல்.

மேற்கூறப்பட்ட கோட்பாடுகளுக்கு ஏற்றதாக செயல்படுத்தலுக்காக நோக்கு , பணிக்கூற்று , குறிக்கோள்கள், பிரதான கொள்கைக்கூற்றுகள் (Key Policy Statements) பின்வருமாறு அமையப்பெற்றுள்ளன.

தார நோக்கு

ஒரு சுகாதார தகவல் கட்டமைப்பானது பராமரிப்பு பெறுபவரின் தனி உரிமை பேணும் தன்மை (Privacy) ரகசியத்தன்மை பேணல் என்பவற்றை உறுதிப்படுத்துவதோடு வினைத்திறன் மிக்கதாய் சமத்துவம் மிக்கதாய், பொருளாதாரத்திற்கு உகந்ததாய் , தரம் மிக்க சுகாதார சேவையை வழங்குவதாயும் அமைய உந்துதல் வழங்குதல்.

பணிக்கூற்று

தரமான , காலத்திற்கு ஏற்ற சுகாதாரத் தகவல்களை சான்று அடிப்படையிலான தீர்மானங்களை எடுப்பதற்கு, வழங்குவதற்கு எங்கும் பரந்திருக்கும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடைய ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நெகிழ்ச்சித் தன்மையுள்ள, தொடர் செயற்பாடுடைய, பணவிரயம் குறைந்த தொடர்ந்திருக்கக் கூடிய சுகாதார தகவல் கட்டமைப்பை வழங்கல்.

கொள்கைக் குறிக்கோள்கள்

கொள்கையின் விரிவான குறிக்கோள்கள் பின்வருமாறு

1. நிறுவன முகாமைத்துவம் மற்றும் அபிவிருத்திக்காக 50% காலத்திற்கு ஏற்ப தேவையான நேரத்திலான தரமான சுகாதார தகவல்களை செயற்படுத்தி பரப்பி பாவித்து பிரயோகித்தலை உறுதி செய்தல்.
2. 50%மான, தள வைத்தியசாலைகளில் மாவட்ட பொது வைத்தியசாலைகளில் மாகாண பொது வைத்தியசாலைகளில் போதனா வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெறும் பயனாளிகளுக்கு வளம் செறிந்த தனிப்பட்ட சமுதாயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட சுகாதார தகவல் கட்டமைப்பினை பகிர்ந்தும் தொடர்ச்சியாகவும் கிடைக்கக் கூடியவாறு செய்தல்.
3. பராமரிப்பு பெறுநர்களின் இரகசியத்தன்மையைப் பேணுவதோடு , தகவல் கட்டமைப்பிற்குரிய நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றி முடியுமான அளவு தகவல்களை சுகாதார தகவல் கட்டமைப்பில் இருந்து பெறுதலும் பகிர்ந்தலும்.
4. எல்லா தகவல் செயன்முறையின் போதும் தகவல் முறையின் ஒருங்கிணைந்து செயற்படும் தன்மையை உறுதிப்படுத்துவதோடு இலத்திரனியல் சுகாதாரம், சுகாதார தகவல் முகாமைத்துவத்தில் பொருத்தமான புதுமைகள் கண்டுபிடிப்புக்கள், மாற்றங்கள் புகுத்தலும் ஊக்குவித்தலும்.
5. எல்லா சுகாதார தரவுகள் தகவல்களின் பாதுகாப்பு உரிய நிலமையை (மாறாமல் பிறவாகமல் இருக்கும் தன்மையை) உறுதிப்படுத்தல்.
6. சுகாதாரத் தகவல் கட்டமைப்பின் நிலைத்திருக்கும் தன்மையை உறுதிப்படுத்தல்.

இக்கொள்கையானது மேற்குறிப்பிடப்பட்ட குறிக்கோள்களை அடைவதற்கு சுகாதாரத் தகவல்கள் கட்டமைப்பின் பின்வரும் 5 பிரிவுகளை இனம் காணப்படுகின்றது.

1. சுகாதார தகவல்களும் அது தொடர்பான வழங்கலும்
2. சுட்டிகளும் அல்லது குறிகாட்டிகளும்.(Indicators) தரவுகளின் கூற்றுகளும் அல்லது மூலங்களும்(data elements)
3. தரவுகளும் தகவல் முகாமைத்துவமும்.
4. தரவு அல்லது தகவல் பாதுகாப்பு பயன்பெறுநரின் தனியுரிமை பேணும் தன்மை(Privacy) ரகசியத்தன்மை, நெறிமுறைகள், ஒழுங்க விதிக்கோவைகள்.
5. இலத்திரனியல் சுகாதாரம் (E-Health) புதுமை புகுத்தல் மாற்றம் செய்தல் புதிய கண்டுபிடிப்புக்கள்.(Innovations)

கொள்கைக் கூற்றுகள்

1. சுகாதார தகவல் தொடர்புடைய வழங்கல்

1. தகவல் செயல்முறைகள் செய்முறை ஒழுங்கு முறைகள் உட்கட்டமைப்பு மனித வளங்கள் என்பன தரவுகள் முகாமைத்துவத்திற்கும் அதன் வினைத்திறனை கூட்டவும் பொருத்தமானதாகப் பழகிக்கொண்டு கையாளப்படல் வேண்டும்.
2. தகவல் கட்டமைப்புடன் சம்பந்தப்பட்ட அமைப்பு ரீதியான, நிறுவன ரீதியான, தனிப்பட்ட மனித வள ரீதியான செயலாற்றலை(Capacity Building) வளர்க்க வசதியளிக்கப்பட வேண்டும்.
3. சுகாதார தகவல் கட்டமைப்பின் தொடர்ச்சியினை உறுதிப்படுத்த தொடர்ச்சியான வள ஒதுக்கீடு நிதி ஒதுக்கீடு என்பன செய்யப்பட வேண்டும்.

2. குறிகாட்டிகளும் தரவு கூறுகளும்.(Indicators and Data Elements)

1. தகவல் தேவைகளுக்கும் குறிகாட்டிகளுக்கு அமையவும் தகவல் சேகரிப்பு மற்றும் தகவல் தொடர் செயன்முறை ஒழுங்குபடுத்தப்பட வேண்டும்.

2. சுகாதாரம் சம்பந்தமான அரசு, அரசு சார்பற்ற, தனியார் தரவுக் கூறுகளும் அல்லது தகவல்கள் தேசிய சுகாதார தகவல் கட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைக்கப்படலாம்.
 3. தரவு அல்லது தகவல் முகாமைத்துவம்
 1. சுகாதார தகவல் நிர்வாகக் கட்டமைப்பின் வலுப்படுத்தல்.
 2. வாழ்நாள் சுகாதாரப் பதிவு மூலம் (Lifelong health Record) பயன் பெறுநர்களுக்கு தொடர்ச்சியான பராமரிப்பு கிடைத்தலை உறுதிப்படுத்தல்.
 3. சுகாதாரத் தகவல்களின் முறையான பேணல் காப்பகப்படுத்தல் மற்றும் அகற்றல் என்பன சரியாகச் செய்யப்படல் வேண்டும்.
 4. சுகாதாரத் துறைக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் தகவல்கள் பரிமாறப்படுதலை ஊக்குவித்தல்.
 5. தேசிய மற்றும் பிராந்திய மட்டத் தரவுகளின் தரத்திற்குப் பொறுப்பு உரிய அதிகாரிகளுக்கு ஒதுக்கப்படும்.
 6. மிக உயர்ந்த பரந்த அளவு தகவல் பாவனையானது பொருத்தமான தகவல் செயன்முறை, தகவல்களின் உடைய அறிக்கையிடுதலின் தரம் மற்றும் வினைத்திறன் மற்றும் தகவல் கிடைக்கும் வழிமுறைகளை மேம்படுத்தல் போன்றவற்றின் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்படும்.
 4. தரவு / தகவல் பாதுகாப்பு வாடிக்கையார் தனியுரிமை பேணும் தன்மை இரகசியத் தன்மை , ஒழுக்க நெறிக்கோவை

Data Information Security Client Privacy Confidentiality and Ethics

 1. நெறிமுறை அல்லது ஒழுக்கநெறி சார்ந்த நியாயமான தகவல் நடைமுறைகள் வாடிக்கையாளர் தனியுரிமை பேணும் தன்மை, மற்றும் ரகசியத்தன்மை என்பவற்றை உறுதி செய்து தகவல் முகாமைத்துவத்துடன் ஒருங்கிணைக்கப்படல் வேண்டும்.
 2. தரவு மற்றும் தகவல் பாதுகாப்பு வாடிக்கையாளர் தரவுப்பாதுகாப்பினை உறுதி செய்தல் வேண்டும்.
 5. இலத்திரனியல் சுகாதாரம், புதுமை புகுதல் (E-Health and Innovation)
 - 1.1. இலத்திரனியல் சுகாதார நிர்வாக கட்டமைப்பு வலுப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
 - 5.2 தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பத் தீர்வுகளும் புதுக்கண்டுபிடிப்புகளும் சுகாதாரத் தகவல் கட்டமைப்பின் தரம், வினைத்திறன் பயன் பெறுநரின் பாதுகாப்பு, குறைந்த பண விரயம் என்பவற்றையும் பேணும் விதமாக சேர்த்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
 - 5.3 தேசிய சுகாதாரத் தகவல் கட்டமைப்பின் பல்வேறு பிரிவுகளின் தகவல் யாவும் தொடர்ச்சியான தரவுப்பரிமாற்றத்தின் மேற்கொள்வதற்கு ஏற்றபடி உபசுகாதாரத் தகவல் கட்டமைப்புகள் தரமுயர்த்தப்பட வேண்டும்.
 - 5.4 சுகாதாரத் தரவு அல்லது தகவல் களஞ்சியப்படுத்தலை மேம்படுத்தலானது தரவு இழப்பினைக் குறைப்பதற்கு (Data Less) வழி வகுக்கும்.
 - 5.5 சுகாதார தரவு அல்லது தகவல் களஞ்சியப்படுத்தலை மேம்படுத்தலானது தரவுகளின் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்யும்.
 - 5.6 தொடர் வருடாந்த வள மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு இலத்திரனியல் சுகாதார தகவல் முறைமையை நீடித்திருக்கச் செய்யும்.

கொள்கையினை நடைமுறைப்படுத்தல்

இக் கொள்கை சுகாதாரத் தகவல்களை விதிகளின் பிரகாரம் நிர்வகிக்க மற்றும் மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க சுகாதார பராமரிப்பு நிறுவனங்களை வழிகாட்டும் விரிவான ஆவணமாக செயற்படும். சுகாதாரம் போசாக்கு மற்றும் சுதேச மருத்துவதுறை அமைச்சின் சுகாதார தகவல் முகாமைத்துவ அபிவிருத்தி மற்றும் திட்டமிடல் பிரிவின் இயக்குனர்கள் இக் கொள்கை நடைமுறைப்படுத்தலுக்கு பிரதானமானவர்கள் ஆவர். சுகாதார இலக்குகள் தொடர்பான அனைத்து சுகாதாரமுன்னேற்றங்களுக்கு பங்களிக்கும் வகையில் சுகாதார தவல்களை உருவாக்கல், பரப்பல், புகுப்பாய்தல் பயன்படுத்தல் போன்றவற்றிற்கு உரிய முகவர்களுக்கு வழிகாட்டல் மற்றும் மேற்பார்வை செய்வதும் உறுதிப்படுத்துவதும் இயக்குனர்களின் பொறுப்பாகும். மற்றும் உரிய மதிப்பீட்டுப் பொறிமுறையின் மூலம் காலத்திற்கு காலம் தகவல் முறைமையின் குறைகளை நிவர்தி செய்து எளிதாக்குவது இயக்குனர்களின் பொறுப்பாகும். இக் கொள்கைக்குத் தேவையான நடைமுறைத் திட்டங்களை உருவாக்குதலுக்கு தேவையான வழிகாட்டலை வழங்கி இக் கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்த துணை செய்கின்ற தேசிய சுகாதார தகவல் செயல் நுணுக்க திட்டம் (இணைப்பு I) மூலம் இது மேலும் வலுப்படுத்தப்படும். (National Health Information Strategic Plan)

Add. Sec. (MS)	- மேலதிகசெயலாளர் (வைத்தியசேவைகள்)
BH	- ஆதாரவைத்தியசாலை
CMU	- கண்ணிபராமரிப்புபிரிவு
Cons. HI	- சுகாதார தகவல் ஆலோசகர்
D/HI	- பணிப்பாளர்/சுகாதார தகவல்
D/OD	- பணிப்பாளர் /நிறுவன அபிவிருத்தி
D/P	- பணிப்பாளர்/திட்டமிடல்
D/PHSD	- பணிப்பாளர்/தனியார் சுகாதார துறை அபிவிருத்தி
DCS	- தொகைமதிப்புள்ளி விபரத் திணைக்களம்
DDG(P)	- சுகாதார சேவைகள் பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்)
DGH	- மாவட்ட ஆதார வைத்தியசாலை
DGHS	- சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம்
GIS	- புவியியல் தகவல் முறை
HIS	- சுகாதார தகவல் முறை
HIU	- சுகாதார தகவல் பிரிவு
ICT	- தகவல் மற்றும் தொலைத் தொடர்பாடல் தொழில் நுட்பம்
M&E	- கண்காணிக்கல்மற்றும்மதிப்பிடல்

MO/DS-HI	- மருத்துவ உத்தியோகத்தர்/பல் வைத்தியர் – சுகாதார தகவல்
MRR	- சுகாதார ஆவணக்காப்பகம்
NeGS	- தேசிய இலத்திரனியல் சுகாதார வழிகாட்டல்கள் மற்றும் தரநிலைகள்
NeHSC	- தேசிய இலத்திரனியல் சுகாதார வழிகாட்டல் குழு
NHISC	- தேசிய சுகாதார தகவல் வழிகாட்டல் குழு
NHSL	- இலங்கை தேசிய வைத்தியசாலை
PDHS	- மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர்
PGH	- மாகாண பொது வைத்தியசாலை
PHN	- தனிப்பட்ட சுகாதார இலக்கம்
RDHS	- பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் திணைக்களம்
RGD	- பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களம்
SH	- சுகாதார செயலாளர்
TH	- போதனா வைத்தியசாலை
UADS	- தரவுக்கான பயன் ஒப்பந்தங்கள்/தகவல் பகிர்வு
WGIE	- கண்டுபிடிப்பு மற்றும் இலத்திரனியல் சுகாதாரம் மீதான பணிக்குழு
WGIPR	- தகவல் செயன்முறை மீள் பொறியியல் பணிக்குழு
WHO	- உலக சுகாதார நிறுவனம்

கொள்கை பகுதி 1 : சுகாதார தகவலுடன் தொடர்புபட்ட வளங்கள்

வழிகாட்டல் கொள்கை 1.1 : வினைத்திறனை மேம்படுத்துவதற்கு தரவு முகாமைத்துவத்திற்கான தகவல் செயன்முறைகள், நடைமுறைகள், உட்கட்டமைப்புகள், மற்றும் மனித வளங்கள் கொள்கைகள் என்பன துல்லியமாக மேற்கொள்ள வேண்டும்.

செயல் நுணுக்கம்	பிரதான செயற்பாட்டு பகுதிகள்/ அமுலாக்கல் வழிகாட்டல்கள்	கால அளவு ¹	பொறுப்பு
1.1.1 தகவல் செயன்முறைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் சுகாதார தகவல் செயன்முறையின் நவீனப்படுத்துகை மற்றும் மேம்படுத்துகையினை உறுதிப்படுத்தல்	1.1.1.1 தேசிய சுகாதார தகவல் வழிகாட்டல் குழு (NHISC) இதன் கீழ் தகவல் செயன்முறை முகாமைத்துவத்திற்கான (தகவல் செயன்முறை மீள் பொறியியல் பணிக்குழு – WGIPR)பணிப்பாளர்/சுகாதார தகவல் (D/HI)இன் தலைமையில் தேசிய மட்ட நிரந்தர தொழில் நுட்ப குழு ஒன்றை நிறுவுதல்	3 மாதங்கள்	தேசிய சுகாதார தகவல் வழிகாட்டல் குழு, பணிப்பாளர்/சுகாதார தகவல்
	1.1.1.2 குறித்த கால இடைவெளியில் தகவல் செயல் முறைகளை மதிப்பிடல், இடைவெளிகளை இனங்கண்டுஅவற்றை மேம்படுத்தி பாலமிடுவதற்காக பரிந்துரைகளைச் செய்தல், தகுந்த தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கி மீள் சுட்டமைத்தல்.	ஆரம்ப மதிப்பீட்டிற்காக 6 மாதங்கள் மற்றும் தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள்	தேசிய சுகாதார தகவல் வழிகாட்டல் குழுவின் கீழ் தகவல் செயன்முறை மீள் பொறியியல் பணிக்குழு
	1.1.1.3 புதிய தகவல் செயன்முறைகளை 1.1.1.2 இன் கீழ் அடையாளங்காணப்பட்ட புதிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு நிறுவுதல்.	24 மாதங்கள்	தேசிய சுகாதார தகவல் வழிகாட்டல் குழுவின் கீழ் தகவல் செயன்முறை மீள் பொறியியல் பணிக்குழு

1 ஒவ்வொரு பிரதான செயற்பாட்டு பகுதிகள் அமுலாக்கல் வழிகாட்டல்கள் அமுலாக்கத்திற்கான கால அளவு இக்கொள்கை அமுலுக்கு வரும் காலப்பகுதியிலிருந்து கணக்கிடப்படும்.

செயல் நுணுக்கம்	பிரதான செயற்பாட்டு பகுதிகள்/ அமுலாக்கல் வழிகாட்டல்கள்	கால அளவு ¹	பொறுப்பு
1.1.2 தகவல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பாடல் தொழில் நுட்ப (ICT) உட்கட்டமைப்பு, தகவல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பாடல் தொழில் நுட்ப(ICT) கருவிகளும் மென்பொருட்களும் தகவல் முறை தன்னியக்கங்களில் தகவல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பாடல் தொழில் நுட்ப வளங்களின் உகந்த மற்றும் தெளிவான பயன்பாட்டினை உறுதிப்படுத்தல்.	1.1.2.1 தன்னியக்க காரணத்திற்காகதகவல் மற்றும் தொலைத் தொடர் பாடல் தொழில் நுட்ப (ICT)கருவிகளையும் தேசிய இலத் திரனியல் சுகாதார வழிகாட்டல்கள் மற்றும் தரநிலைகளின் (NeGS)பிரகாரம் தகவல் மற்றும் தொலைத் தொடர் பாடல் தொழில் நுட்ப (ICT)உட்கட்டமைப்புகளையும் பெற்றுக்கொள்ளல்.	தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள்	அனைத்து பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகங்களும்
	1.1.2.2தெளிவாகவும் தேசிய இலத்திரனியல்சுகாதார வழிகாட்டல்கள் மற்றும் தரநிலைகளின் (NeGS) பிரகாரமும் சுகாதார தரவுக் களஞ்சியங்கள் மற்றும் சுகாதார மென் பொருளிற்கான சேவையக வசதியினை தேசிய, துணைத் தேசிய அத்துடன்/ அல்லது நிறுவன மட்டத்தில் நிறுவுதல் அத்துடன்/அல்லது பராமரித்தல் அல்லது பயன்படுத்தல்	24 மாதங்கள்	சுகாதார செயலாளர், பணிப்பாளர்/சுகாதார தகவல் (திட்டமிடல்), பணிப்பாளர்/சுகாதார தகவல்
	1.1.2.3 தேசிய இலத்திரனியல் சுகாதார வழிகாட்டல்கள் மற்றும் தரநிலைகளின் (NeGS) பிரகாரம்பயனுடைய ஒன்றாக அலுவலக பாவனைக்காக இணைய இணைப்பினை வழங்குதல்	24 மாதங்கள்	சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம், பணிப்பாளர்/சுகாதார தகவல்
	1.1.2.4. கணனி பராமரிப்பு பிரிவினா டாக இலத்திரனியல் வன் பொருள் மற்றும் கணனி வலைதளங்களிற்கான தள பராமரிப்பு மற்றும் தவறுகளை இனங்கண்டு சீர் செய்வதற்கான பொறிமுறை ஒன்றினை நிறுவுதல்.	12 மாதங்கள்	சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம், பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்), பணிப்பாளர்/ சுகாதார தகவல்
	1.1.2.5. சுகாதார நலத்துறைகளில் தேசிய இலத்திரனியல் சுகாதார வழிகாட்டல்கள் மற்றும் தரநிலைகளின் (NeGS) பிரகாரம் உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி திட்டங்களில் தகவல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பாடல் தொழில் நுட்பத்தினை (ICT) உருவாக்குதல்	தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள்	சுகாதார செயலாளர், அனைத்து பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகங்களும்
வழிகாட்டல் கொள்கை 1.2 : சுகாதார தகவலுடன் தொடர்புபட்ட அமைப்பு, நிறுவன மற்றும் தனி மனித வள திறன் விருத்தி வளர்ச்சி செய்யப்பட வேண்டும்			
செயல் நுணுக்கம்	பிரதான செயற்பாட்டு பகுதிகள்	கால அளவு	பொறுப்பு
1.2.1 மனித வளம்			
சுகாதார தகவல் முகாமைத்துவத்திற்காக வழங்கப்பட்டுள்ள மனித வளங்கள் பலப்படுத்தப்பட வேண்டும்	1.2.1.1 சுகாதார தகவல் முகாமைத்துவம் மற்றும் தகவல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பாடல் தொழில் நுட்பத்திற்கான தெளிவான கட்டமைப்பினை குறித்த கால இடைவெளியில் மீள்பார்வை செய்து திருத்தியமைத்தல்.	தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள்	பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்), பணிப்பாளர்/ திட்டமிடல், பணிப்பாளர்/ சுகாதார தகவல்

செயல் நுணுக்கம்	பிரதான செயற்பாட்டு பகுதிகள்	கால அளவு	பொறுப்பு
	1.2.1.2.தகவல் மற்றும் தொலைத் தொடர்பாடல் தொழில் நுட்ப திறன் விருத்தி, தனியார் சுகாதார நல நிறுவனங்களிலுள்ளோர் உட்பட தற்போதுள்ள சுகாதார ஊழியர்களின் மனப்பாங்குகள் மற்றும் பழக்கவழக்கங்கள் என்பனவற்றை சுகாதார செயன்முறையில் உகந்த முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும்.	தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள்	சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம், பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்)
	1.2.1.3 சுகாதார தகவல் முகாமைத்துவம் மற்றும் தகவல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பாடல் தொழில் நுட்ப ஊழியர்களுக்கான தொடர்ச்சியான தொழில்வாண்மை விருத்தியினையும் உரிய பயிற்சியினையும் வழங்குதல்.	தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள்	பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்), பணிப்பாளர் / சுகாதார தகவல்
	1.2.1.4 இறந்தவர்கள் மற்றும் நோயுற்றவர்கள் பற்றிய ஆவணங்களை குறியீடு செய்து வைத்திருப்பதற்குரிய சுகாதார ஊழியர்கள் மற்றும் வைத்திய மாணவர்கள் ஆகியோருக்கு பயிற்சியினை வழங்குதல்.	தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள்	பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்), பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (வைத்திய சேவைகள்), பணிப்பாளர் / சுகாதார தகவல், பிரதிப் பணிப்பாளர் / வைத்திய சேவைகள் பிரிவு
வழிகாட்டல் கொள்கை 1.3 : சுகாதார தகவல் முறையின் ஸ்திரத்தன்மைக்காக தொடர்ச்சியான வருடாந்த வள ஒதுக்கீடு மற்றும் நிதி உறுதிப்படுத்தப்படல் வேண்டும்.			
செயல் நுணுக்கம்	பிரதான செயற்பாட்டு பகுதிகள் / அமுலாக்கல் வழிகாட்டல்கள்	கால அளவு	பொறுப்பு
1.3.1. சுகாதார தகவல் முறையின் ஸ்திரத் தன்மை சுகாதார தகவல் முறையின் அனைத்து நவீனமயமாக்கல் முயற்சிகளும் ஸ்திரத்தன்மை பற்றி கவனம் செலுத்த வேண்டும்	1.3.1.1 இவ் மூலோபாய திட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்ட திட்ட அமுலாக்கத்திற்கான சுகாதார தகவல் வரவு செலவு திட்ட வரிசையினை அடையாளங்காணல்	12 மாதங்கள்	சுகாதார செயலாளர், சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம்
1.3.2 வள திரட்டுகை சுகாதார தகவல் மற்றும் சுகாதார தகவல் முறை முகாமைத்துவம் என்பனவற்றிற்காக வளங்களைத் திரட்டி வசதிப்படுத்தல்	1.3.2.1 உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி மற்றும் மனித வள திறன் விருத்தி ஆகியன இணைந்த வகையில் தேசிய மற்றும் துணை தேசிய மட்டங்களில் தகவல் முறை நவீனமயப்படுத்துகை செயற்பாட்டுத் திட்டங்களை நடைமுறைக்கேற்ற வகையில் படிப்படியாக அபிவிருத்தி செய்து அமுலாக்குதல்	12 மாதங்கள்	சுகாதார செயலாளர், சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம், அனைத்து மாகாண சுகாதார செயலாளர்கள், அனைத்து சுகாதார சேவைகள் மாகாண பணிப்பாளர்
	1.3.2.2 முறையான நீக்குகைகள் மூலமும் பெறுமதி தரு மாற்றுகைகள் மூலமும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களை உருவாக்குதல்	தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள்	சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம், அனைத்து சுகாதார சேவைகள் மாகாண பணிப்பாளர், தேசிய சுகாதார தகவல் வழிகாட்டல் குழுவின் கீழ் தகவல் செயன்முறை மீள் பொறியியல் பணிக்குழு. பணிப்பாளர்/சுகாதார தகவல்

கொள்கை பகுதி 2 : குறிகாட்டிகள் மற்றும் தகவல் கூறுகள்			
வழிகாட்டல் கொள்கை 2.1 :தகவல் தேவைகள் மற்றும் அனைத்து மட்டங்களிலும் உள்ள குறிகாட்டிகளுடன் சுகாதார தரவு சேகரித்தல் மற்றும் தொடர்புபட்ட தகவல் செயன்முறைகள் சீரமைக்கப்பட வேண்டும்.			
செயல் நுணுக்கம்	பிரதான செயற்பாட்டு பகுதிகள் / அமுலாக்கல் வழிகாட்டல்கள்	கால அளவு	பொறுப்பு
2.1.1 குறிகாட்டிகள் தேசிய, துணைத் தேசிய மற்றும் நிறுவன மட்டங்களில் குறைந்தபட்ச குறிகாட்டி தொகுதிகளை அடையாளங்காணல்	2.1.1.1 தேசிய, துணைத் தேசிய மற்றும் நிறுவன மட்டங்களில் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பிடல் (கண்காணித்தல் மற்றும் மதிப்பிடல்)கட்டமைப்புகள் உட்பட தகவல் தேவைகளை அடையாளங்காணல்.	ஆரம்ப மதிப்பீட்டிற்காக 6 மாதங்கள்	பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்), பணிப்பாளர் / சுகாதார தகவல்
	2.1.1.2 தேவைப்படும் குறைந்தபட்ச தரவு கூறுகள் உட்பட அடையாளங்காணப்பட்ட தரவு தேவைகளை திருப்தி செய்வதற்கு குறைந்தபட்ச குறிகாட்டி ஒன்றை வரையறை செய்தல். பிரயோகிக்கக்கூடிய வேளைகளில் சர்வதேச ரீதியில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட குறிகாட்டிகளுக்கு இணையாக இருப்பதற்கு இவைகள் சிபாரிசு செய்யப்படுகின்றன .	12 மாதங்கள்	பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்), ஒழுங்கமைப்பு அபிவிருத்தி பணிப்பாளர், பணிப்பாளர் /சுகாதார தகவல்
	2.1.1.3 செயன்முறை மேம்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக குறிகாட்டிகளை குறித்த கால இடைவெளியில் மீள்பார்வை செய்தல்	தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள்	பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்), பணிப்பாளர் / சுகாதார தகவல், தேசிய சுகாதார தகவல் வழிகாட்டல் குழுவின் கீழ் தகவல் செயன்முறை மீள் பொறியியல் பணிக்குழு
2.1.2 தரவுக் கூறுகள், தரவு தரநிலைகள் மற்றும் மேனிலைத் தரவு (Meta-Data) தரவுக் கூறுகள் மற்றும் அவற்றின் பொருள் கோடலின் ஒத்த தன்மையினை உறுதிப்படுத்துதல்	2.1.2.1 தகவல் செயன்முறை மீள் பொறியியல் பணிக்குழுவுடனான ஆலோசனையில் தொடர்புபட்ட தேசிய அமைப்பின் தொடர்புகளைப் பேணுவதற்கு தற்போதுள்ள தரவு சேகரிப்பு விண்ணப்பங்கள் மற்றும் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தரவுக் கூறுகளையும் கால இடைவெளியில் மீள் பார்வையிடல். மீள் பார்வையிடப்பட்ட அமைப்புகள் உகந்த இடங்களில் எதிர்கால தன்னியக்கத்திற்கு ஊக்குவித்து உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும்.	தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள்	அனைத்து பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகங்கள், பணிப்பாளர் /சுகாதார தகவல், தேசிய சுகாதார தகவல் வழிகாட்டல் குழுவின் கீழ் தகவல் செயன்முறை மீள் பொறியியல் பணிக்குழு
	2.1.2.2 தேசிய மட்டத்தில் தரவுத் தரநிலைகள், தரவு வரைவிலக்கணங்கள் (தரவு அகராதி ஒன்றை விருத்தி செய்து பேணல்) மற்றும் மேனிலைத் தரவு (அநவய-னவய) என்பனவற்றை வரையறுத்து கால இடைவெளியில் மீள் பார்வை செய்தல்.	6 மாதங்கள் ஆரம்ப செயற்பாடு மற்றும் தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள்	பணிப்பாளர் /சுகாதார தகவல், தேசிய சுகாதார தகவல் வழிகாட்டல் குழுவின் கீழ் தகவல் செயன்முறை மீள் பொறியியல் பணிக்குழு

செயல் நுணுக்கம்	பிரதான செயற்பாட்டு பகுதிகள்	கால அளவு	பொறுப்பு
2.1.3தகவல் செயன்முறைகள் பாவனையாளரால் குறிப்பிடப்பட்டு வழங்கப்பட்ட வரையறுக்கப்பட்ட தரவுத் தொகுதிகளை கவர்வதற்குதரவுச் செயன் முறைகளைஒழுங்குபடுத்தல்,	2.1.3.1அடையாளங்காணப்பட்ட குறைந்தபட்ச தரவுத் தொகுதிகளுடன் ஒழுங்குபடுத்துவதற்குதரவு செயன் முறைகளை மேம்படுத்தி நிறுவுதல்.	18 மாதங்கள்	பணிப்பாளர்/சுகாதார தகவல், பணிக்குழு
	2.1.3.2 தரவு சேகரிப்பு, தரவு சேகரிப்பு கருவிகள்/விண்ணப்பங்கள் அல்லது அறிக்கையிடும் முறைகள் என்பனவற்றின் மாறுகின்ற தேவைகளை வசதிப்படுத்தி ஒருங்கிணைத்தல்.	தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள்	தேசிய நிகழ்ச்சிகள்/ பிரிவுகள் தொடர்பானவை, தேசிய சுகாதார தகவல் வழிகாட்டல் குழுவின் கீழ் தகவல் செயன்முறை மீள் பொறியியல் பணிக்குழு
வழிகாட்டல் கொள்கை 2.2 :சுகாதாரம் மற்றும் சுகாதாரத்துடன் தொடர்புபட்ட தரவுக் கூறுகள்/அரசு மற்றும் அரச சார்பற்ற துறைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்கள் தேசிய சுகாதார தகவல் முறைக்குள் ஒருங்கிணைக்கப்பட வேண்டும்.			
செயல் நுணுக்கம்	பிரதான செயற்பாட்டு பகுதிகள்/ அமுலாக்கல் வழிகாட்டல்கள்	கால அளவு	பொறுப்பு
2.2.1 அரசு மற்றும் அரச சார்பற்ற சுகாதார தரவு/ தகவல் தொடர்புபடும் அனைத்து அரச மற்றும் அரச சார்பற்ற முகவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட சுகாதார தரவு/ தகவல்களை சுகாதார தகவல் முறைக்குள் இணைத்துக் கொள்ளல்	2.2.1.1 அரசு மற்றும் அரச சார்பற்ற முகவர்களிடமிருந்து(தனியார் சுகாதார துறை உள்ளடங்கலாக) தேசிய சுகாதார தகவல் முறைக்கு அனுப்ப வேண்டிய சுகாதாரத்துடன் தொடர்புபட்ட குறைந்த பட்ச தரவுக் கூறுகளை இனங்காணல்.	6 மாதங்கள்	பணிப்பாளர்/தனியார் சுகாதார துறை அபிவிருத்தி , பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்), பணிப்பாளர்/சுகாதார தகவல், தேசிய சுகாதார தகவல் வழிகாட்டல் குழுவின் கீழ் தகவல் செயன்முறை மீள் பொறியியல் பணிக்குழு
2.2.2 நோய் கண்காணிப்பு செய்யப்பட்ட நோய்களை ஒழுங்காக கண்காணிப்பதற்காக கண்காணிப்பு முறையினை பலப்படுத்தல்	2.2.1.2 அரசு (சுகாதாரத்தை விடவும்) மற்றும் அரச சார்பற்ற முகவர்களிடமிருந்து (தனியார் சுகாதார துறை உள்ளடங்கலாக) சுகாதாரத்துடன் தொடர்புபடும் தரவுக் கூறுகளை அறிக்கையிடும் பொறிமுறை ஒன்றை நிறுவுதல்.	18 மாதங்கள்	சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம், பணிப்பாளர்/சுகாதார தகவல், பணிப்பாளர்/ தனியார் சுகாதார துறை அபிவிருத்தி, தேசிய சுகாதார தகவல் வழிகாட்டல் குழுவின் கீழ் தகவல் செயன்முறை மீள் பொறியியல் பணிக்குழு
	2.2.2.1 தெரிவு செய்யப்பட்ட நோய்களுக்கான கண்காணிப்பு முறைகளைப் பலப்படுத்தல்.	12 மாதங்கள்	தொடர்புடைய தேசிய நிகழ்ச்சிகள்/பிரிவுகள், தேசிய சுகாதார தகவல் வழிகாட்டல் குழுவின் கீழ் தகவல் செயன்முறை மீள் பொறியியல் பணிக்குழு
2.2.3 தேசிய சனத்தொகை கணக்கெடுப்பு மற்றும் தேசிய மதிப்பாய்வு தேசிய சனத்தொகை கணக்கெடுப்பிலிருந்து சுகாதார தரவினை பிரிப்பதற்கு பொறிமுறையினை பலப்படுத்தல்.	2.2.3.1 தேசிய சனத்தொகை கணக்கெடுப்பிலிருந்து சுகாதாரத்துடன் தொடர்புபட்ட தரவுக் கூறுகளை இனங்கண்டு பிரித்தெடுத்தல்.	12 மாதங்கள்	சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் , தொகைமதிப்பு புள்ளி விபரத் திணைக்களம் , பணிப்பாளர் / சுகாதார தகவல், தேசிய சுகாதார தகவல் வழிகாட்டல் குழுவின் கீழ் தகவல் செயன்முறை மீள் பொறியியல் பணிக்குழு

3 நிறுவன மட்டம் ஒன்றின் தகவலை முகாமை செய்வதற்கு அமுல்படுத்தப்பட்ட பஸ்தரப்பட்ட ஒழுக்காற்று கட்டமைப்புகள், கொள்கைகள் நடைமுறைகள், செயல்முறைகள் மற்றும் கடப்பாடுகள் என்பனவற்றின் தொகுதி சுகாதார தகவல் ஆள்கை ஆகும்.

செயல் நுணுக்கம்	பிரதான செயற்பாட்டு பகுதிகள்/ அமுலாக்கல் வழிகாட்டல்கள்	கால அளவு	பொறுப்பு
	சுகாதார தகவல் பற்றிய தேசிய கொள்கை அமுலாக்கத்தினை வசதிப்படுத்தும் பொருட்டு துறை சார் சுகாதார தகவல் முகாமைத்துவத்தின் மீது மத்திய மைய புள்ளியாக சுகாதார, போசனை மற்றும் சுதேச மருத்துவ அமைச்சின் சுகாதார தகவல் பிரிவினை (HIU) வலுவடையச் செய்தல்.	12 மாதங்கள்	சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம்
	3.1.1.3 கிடைமட்ட பிரச்சாரங்களை மாகாண மட்டத்திலும், சம்பந்தப்பட்ட பணிப்பாளர் குழாத்திற்கு சுகாதார சேவைகள் பிராந்திய திணைக்கள மட்டத்திலும் , இலங்கை தேசிய வைத்தியசாலை, விசேட வைத்தியசாலைகள், போதனா வைத்தியசாலைகள், மாகாண தேசிய வைத்தியசாலைகள், மாவட்ட ஆதார வைத்தியசாலைகள் மற்றும் ஆதார வைத்தியசாலைகள் என்பனவற்றிற்கு மையப் புள்ளிகளின் வடிவமைப்புடன் நிறுவன மட்டத்திலும் சுகாதார தகவல் முகாமைத்துவம் பற்றிய சுகாதார தகவல் முகாமைத்துவ பிரிவுகளை நிறுவுதல்.	24 மாதங்கள்	சுகாதார தகவல் ஆலோசகர் அல்லது சுகாதார உத்தியோகத்தர்/பல் வைத்தியர் – சுகாதார தகவல்
	சுகாதார ஆவண அறையினை (ஆசுசு) அனைத்து வைத்தியசாலைகளிலும் தரமுயர்த்துதல்.	24 மாதங்கள்	சுகாதார சேவைகள் பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்), பணிப்பாளர்/சுகாதார தகவல்

வழிகாட்டல் கொள்கை 3.2 : சுகாதார நல பெறுநர்களுக்கான தொடர்ச்சியான நலனை வாழ்நாட்கால ஆவணம் ஒன்றினூடாக உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

செயல் நுணுக்கம்	பிரதான செயற்பாட்டு பகுதிகள்/ அமுலாக்கல் வழிகாட்டல்கள்	கால அளவு	பொறுப்பு
3.2.1 தனித்துவமான சுகாதார அடையாளங் காட்டி-அனைத்து சுகாதார வாடிக்கையாளர்களுக்கும் தனிப்பட்ட சுகாதார இலக்கம் (PHN) வழங்குதல்	3.2.1.1 தொடர்ச்சியான நலனினை (வாழ்நாட் கால சுகாதார ஆவணம்) உறுதிப்படுத்துவதற்கு அனைத்து சுகாதார வாடிக்கையாளர்களுக்கும் தனித்துவமான அடையாளங்காட்டி ஒன்றை வழங்குவதற்கு பொறிமுறை ஒன்றினை ஸ்தாபித்தல். ஒவ்வொரு சுகாதார வாடிக்கையாளர்களுக்கும் சுகாதார நலத்துடனான ஒப்பந்தத்தின் முதலாவது புள்ளியில் இவ் அடையாளங் காட்டி வழங்கப்பட வேண்டும்.	12 மாதங்கள்	பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்), பணிப்பாளர்/சுகாதார தகவல், அனைத்து சுகாதார சேவைகள் மாகாண பணிப்பாளர்கள், அனைத்து நிறுவன தலைவர்கள்
3.2.2 தனிப்பட்ட சுகாதார இலக்கத்தின் பயன் சுகாதார நல பெறுநர்களால் தனிப்பட்ட சுகாதார இலக்கம் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் பயன்படுத்தப்படுவதை வாவேற்றல்	3.2.2.1 சுகாதார நல சந்திப்புக்களில் தனிப்பட்ட சுகாதார இலக்கம் உருவாகியதன் நன்மைகள் தொடர்பாக பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வினை ஏற்படுத்த பொறிமுறையினை ஸ்தாபித்தல்.	தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள்	சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம், பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்)

வழிகாட்டல் கொள்கை 3.3 :முறையான நிறுத்தி வைப்பு, ஆவணப்படுத்தல், சுகாதார தரவு/ தகவல் அகற்றுகை என்பன உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

செயல் நுணுக்கம்	பிரதான செயற்பாட்டு பகுதிகள்/ அமுலாக்கல் வழிகாட்டல்கள்	கால அளவு	பொறுப்பு
	3.4.2.2 உள்ளக மற்றும் உட்துறை தரவு/தகவல் பகிர்விற்கான பயன் உடன்படிக்கைகளால்(UADS) ⁸ தரவு/தகவல் பகிர்விற்கான வழிமுறைகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை ஸ்தாபித்தல்.	18 மாதங்கள்	தேசிய சுகாதார தகவல் வழி காட்டல் குழுவின் கீழ் தகவல் செயன்முறைமீள் பொறியியல் பணிக்குழு, பணிப்பாளர்/சுகாதார தகவல்
வழிகாட்டல் கொள்கை 3.5 :தேசிய மற்றும் துணை தேசிய மட்டங்களிலும் தரவு மற்றும் தகவல் தரத்திற்கான பொறுப்புக்கள் உரிய அதிகார அமைப்புக்களிற்கு ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும்.			
செயல் நுணுக்கம்	பிரதான செயற்பாட்டு பகுதிகள்/ அமுலாக்கல் வழிகாட்டல்கள்	கால அளவு	பொறுப்பு
3.5.1. தரவு /தகவல் தரம் தரவு மற்றும் தகவலின் நேர வரை மற்றும் தரத்தினை உறுதிப்படுத்துதல்	3.5.1.1முடிந்தவரையில் தரவுத் தரத்தினை கைப்பற்றுதலினை உறுதிப்படுத்துவதற்கு உள்ளமைக்கப்பட்ட பொறிமுறைகளை ஸ்தாபித்தல்.	24 மாதங்கள்	தேசிய சுகாதார தகவல் வழி காட்டல் குழுவின் கீழ் தகவல் செயன்முறைமீள் பொறியியல் பணிக்குழு, பணிப்பாளர்/சுகாதார தகவல்
	3.5.1.2 சுகாதார தகவலை உரிய நேரத்திலும், தரத்துடனும் வழங்கு வதற்காக மாகாண மற்றும் பிராந்திய சுகாதார நிறுவனங்களில் சுகாதார நிர்வாகிகள், விசேட நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பிரச்சாரங்கள், வைத்தியசாலைகள், பொது சுகாதார நிறுவனங்கள் மற்றும் சுகாதாரத்துறை என்பனவற்றை உருவாக்குதல்.	தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள்	சுகாதார செயலாளர், சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம், மாகாண சுகாதார செயலாளர்கள்
	3.5.1.3 அனைத்து தகவல் செயன் முறைகளுக்கும் வழக்கமான மற்றும் கடினமான தர உறுதிப்பாடு மற்றும் தர கட்டுப்பாடு மற்றும் தர கட்டுப்பாட்டு நடைமுறைகளை (கண்காணிப்பு மற்றும் பின்னூட்டல் பொறிமுறைகள் உட்பட) உருவாக்குதல்.	24 மாதங்கள்	சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம், பணிப்பாளர்/சுகாதார தகவல்
வழிகாட்டல்கொள்கை 3.6 :சுகாதார தரவு/தகவலின் உயரியமற்றும்பரந்தபாவனையானது அனைத்துபங்குதாரர்களினாலும்தெளிவான தரவு செயன்முறை, சுகாதார தகவல் அறிக்கையின் விருத்தி செய்யப்பட்ட வினைத்திறன் மற்றும் தரம், சுகாதார தகவலின் விருத்தி செய்யப்பட்ட அணுகு முறை என்பனவற்றினூடாக உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.			
செயல் நுணுக்கம்	பிரதான செயற்பாட்டு பகுதிகள்/ அமுலாக்கல் வழிகாட்டல்கள்	கால அளவு	பொறுப்பு
3.6.1 சுகாதார தகவல் அறிக்கைகள் மற்றும் புள்ளி விபர அறிக்கைகள் சர்வதேச, தேசிய மற்றும் துணை தேசிய மட்டங்களிலுள்ள உத்தேசிக் கப்பட்ட பார்வையாளர்களின் தேவைகளை சந்திப்பதற்கு உயரிய தரம், காலாண்டு மற்றும் வருடாந்த சுகாதார தகவல் அறிக்கைகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளதை உறுதிப்படுத்துதல்.	3.6.1.1 மாகாண, பிராந்திய, விசேட பிரிவு, நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பிரச்சாரம் அத்துடன் சுகாதார, போசனை மற்றும் சுதேச மருத்துவ அமைச்சின் தொடரமைச்சு நிறுவன மட்டத்தில் வரும் ஆண்டின் முதற் காலாண்டின் இறுதியினை விடவும் தாமதிக்காது குறைந்தபட்ச வருடாந்த புள்ளிவிபர அறிக்கை ஒன்றை வெளியிடல்.	தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள்	சம்பந்தப்பட்ட பணிப்பாளர் குழுக்கள்

8. பணிப்பாளர் குழுவும் விசேட நிகழ்ச்சிகள், பிரச்சாரம் மற்றும் நிறுவனங்கள் மத்தியில் தரவுத் தகவல் பகிர்விற்கான பயன் உடன்படிக்கையினை வரையறையின்றி பிரயோகித்தல் வேண்டும். மட்ட சுகாதார சேவைகள் மாகாண பணிப்பாளர் மற்றும் சுகாதார சேவைகள் பிராந்திய திணைக்களத்திற்கான தகவல் பகிர்வு மற்றும் அறிக்கையிடல் பொறிமுறை தெளிவாக ஸ்தாபிக்கப்பட்ட அல்லது பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களம் தொகை மதிப்பு புள்ளி விபரத் திணைக்களம், கல்வித் திணைக்களம் மற்றும் பொலிஸ் திணைக்களம் ஆகியவற்றுடன் பகிர்வதற்கு உள்ளகத்துறை தகவல் பகிர்வு வரையறை இன்றி உள்ளடக்கப்பட வேண்டும்.

10 தேசிய முக்கியத்துவத்தின் சகாதாரம், நேரம், தரவு தகவல் என்பவற்றை புவியியல் ரீதியாக குறிப்பிடுவதற்கு நடுத்தரமாக பராமரிக்கப்படும் ஏடு ஒன்றை புவியியல் தகவல் முறை சகாதார ஏடு ஆகும்.

செயல் நுணுக்கம்	பிரதான செயற்பாட்டு பகுதிகள்/ அமுலாக்கல் வழிகாட்டல்கள்	கால அளவு	பொறுப்பு
	3.6.3.2 சுகாதார நிலை மற்றும் சேவை விநியோகம் என்பவற்றை பிரதிபலிப்பதற்கு உள்வாரி மற்றும் வெளிவாரி பாவனையாளர்களுக்கான தேசிய சுகாதார ஆய்வகம் ¹¹ அல்லது முகப்புப் பெட்டி ஒன்றினை ஸ்தாபித்தல்.	36 மாதங்கள்	பணிப்பாளர்/சுகாதார தகவல், பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்)
	3.6.3.3 பொதுமக்களிற்கு அவர்களது சமூக பொறுப்புணர்விற்காக சுகாதார தகவலை வழங்குவதற்கு அரசு மற்றும் தனியார் ஊடகங்களிற்கான வழிமுறைகளை ஸ்தாபித்தல்.	18 மாதங்கள்	சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம், பணிப்பாளர்/சுகாதார கல்வி பணியகம்
	3.6.3.4 சுகாதார வலை நுழைவாயிலை குடிமக்களை மையப்படுத்திய ஒன்றாக ஸ்தாபித்து உரிய நேரத்திற்கு தரவேற்றல்	12 மாதங்கள்	பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்), பணிப்பாளர்/ சுகாதார தகவல்
3.6.4 தகவல் கலாச்சாரம் சுகாதார துறையினரிடையேதரவு செயன்முகாமை மற்றும் தகவலிற்கான அமைப்பொன்றின் செயன்முகாமையினை உருவாக்கம் என்பனவற்றினூ டாக அனைத்து மட்டங்களிற்கும் ஆதாரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டுதீர்மானம் மேற்கொள்ளல் மற்றும் பொறுப்புணர்வை மேம்படுத்தல்.	3.6.4.1 அனைத்து மட்டங்களிற்கும் முன்மொழியப்பட்ட செயற்பாடுகளிற்கான சுகாதார தகவல் முறையினை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆதாரத்தைக் குறிப்பிடுவதற்கு திட்டம் மற்றும் பயிற்சி சமர்ப்பிப்புக்கள் அனைத்தையும் அதிகாரம் மிக்கதாக்குவதற்கான வழிமுறைகளை ஸ்தாபித்தல்	24 மாதங்கள்	சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம்
	3.6.4.2 அனைத்து மட்டங்களிலும் செயலாற்றுகை எல்லைகள் மற்றும் இலக்குகளை தொகுத்தும், கணித்தும் சுகாதார தகவலை உருவாக்குவதற்கு வழிமுறைகளை ஸ்தாபித்தல்	24 மாதங்கள்	சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம்
கொள்கை பகுதி 4 : தரவு/தகவல் பாதுகாப்பு, வாடிக்கையாளர் தனிப்பட்டவை, நம்பகத்தன்மை மற்றும் நெறிமுறைகள்			
வழிகாட்டல் கொள்கை 4.1 : வாடிக்கையாளரின் தனிப்பட்ட மற்றும் நம்பகத்தன்மையினை உறுதிப்படுத்துவதற்கு தகவல் முகாமைத்துவத்தின் நெறிமுறைகள் மற்றும் நியாயமான தகவல் பயிற்சியினை உருவாக்குதல் வேண்டும்			

11 நாட்டின் சுகாதாரத்துடன் தொடர்புபட்ட புள்ளி விபரங்களுக்கான நுழைவாயில் ஒன்றாகவும் உலக சுகாதார அமைப்பின் உலக சுகாதார ஆய்வகம் (GHO இற்கு இணையானதாகவும் சுகாதார ஆய்வகம் உள்ளது.)

செயல் நுணுக்கம்	பிரதான செயற்பாட்டு பகுதிகள்/ அமுலாக்கல் வழிகாட்டல்கள்	கால அளவு	பொறுப்பு
4.1.1 நியாயமான தகவல் பயிற்சிகள் அனைத்து சுகாதார தரவு/தகவலிற்கும் தெளிவான, நியாயமான தகவல் பயிற்சிகளை அமுலாக்குதல்	4.1.1.1 இணக்கம், பயன்பாடு, எழுதப்பட்ட ஒரு காரணம், செயல் முறையை தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய ஒருதேவை, திருத்துவதற்கான திறன் மற்றும் தனியார் சம்மதம் என்பனவற்றின் தரங்கள் செயற்பாட்டிற்கு தனி நபரினால் அடையாளம் காணக்கூடிய தரவு/தகவல் சேகரிப்பிற்கான வழி முறைகளை ஸ்தாபித்தல்	24 மாதங்கள்	சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம், பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (கல்வி, பயிற்சி மற்றும் ஆய்வு), பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்)
	4.1.1.2 அடையாளம் காணக்கூடிய தரவு/தகவல் மற்றும் சுகாதார தரவு/தகவல் என்பனவற்றின் கட்டுப்பாடான செயல் முறைகளை உறுதிப்படுத்துவதற்கு சுகாதார தகவல் துணை முறையின் வழி முறைகள் மற்றும் பயன்பாட்டு பொறி முறைகளை ஸ்தாபித்தல் தகவல் செயல்முறை கட்டுப்பாட்டு வகிபங்கினை அடிப்படையாகக்கொண்டிருக்கவேண்டும் என்பதுடன் அறிவதற்கான தேவை மற்றும் அடிப்படையில் செய்வதற்கான தேவையினையும் கொண்டிருக்க வேண்டும்	24 மாதங்கள்	பணிப்பாளர்/சுகாதார தகவல், பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்)
	4.1.1.3 வாடிக்கையாளர் தனிப்பட்டவை, நம்பகத்தன்மை மற்றும் நெறிமுறையான தகவல் பயிற்சியின் கருத்து பற்றி சுகாதார ஊழியருக்கு கல்வி புகட்டுதல்	தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள்	பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்)
4.1.2 பெயரிடப்படாமை மற்றும் புனைப்பெயர் கைநூல் மற்றும் இலத் திரனியல் சுகாதார தகவல் முறைகளில் எல்லா வேளைகளிலும் பெயரிடப் படாமை மற்றும் புனைப் பெயரின் கொள்கைகள் பாதுகாக்கப்படுவதை உறுதிசெய்தல்	4.1.2.1 சுகாதார வாடிக்கையாளர் இனங்காணுகை, சுகாதார நலன் பெறுநரின் தனிப்பட்ட விடயங்கள், நம்பகத்தன்மை ஆகியனவற்றைப் பாதுகாத்தல் என்பனவற்றிற்காக தனித்துவமான தனிப்பட்ட சுகாதார இலக்கத்தினை(PHN) வடிவமைத்து பயன்படுத்துதல்.	12 மாதங்கள்	பணிப்பாளர்/சுகாதார தகவல், பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்)
	4.1.2.2 பெயரிடப்படாமை மற்றும் புனைப்பெயரின் கருத்துப் பற்றி சுகாதார ஊழியருக்கு கல்வி புகட்டுதல்.	தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள்	சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம், பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்), பணிப்பாளர்/சுகாதார தகவல்
4.1.3 சுகாதார நலன் பெறுநர்களிற்கு அதிகாரம் வழங்குதல் சுகாதார நலன் பெறுநர்களின் நம்பகத்தன்மையிற்கான உரிமையினை பயன்படுத்துவதற்கு அதிகாரமளித்தல்.	4.1.3.1 தனிப்பட்ட, நியாயம், தகவல் பயிற்சிகள், பெயரிடப்படாமை மற்றும் புனைப்பெயரின் கொள்கைகள் பற்றி சுகாதார நலன் பெறுநர்களிற்கு கல்வி புகட்டுதல்.	தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள்	சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம், பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்),பணிப்பாளர்/சுகாதார தகவல்

செயல் நுணுக்கம்	பிரதான செயற்பாட்டு பகுதிகள்/ அமுலாக்கல் வழிகாட்டல்கள்	கால அளவு	பொறுப்பு
	5.1.1.4 மென்பொருள் மற்றும் இலத்திரனியல் சுகாதார முறைகளை கையகப்படுத்தல், பராமரித்தல் மற்றும் நீக்குதலிற்கான வழிமுறைகளை உருவாக்குதல்.	24 மாதங்கள்	பணிப்பாளர்/சுகாதார தகவல், பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்)
வழிகாட்டல் கொள்கை 5.2:தரம், வினைத்திறன், நோயாளர் பாதுகாப்பு மற்றும் பெறுமதி பயன் தரு சுகாதார தகவல் முறைகள் விருத்தியாவதற்கு இலத்திரனியல் சுகாதார தீர்வுகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் தெளிவாக ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும்.			
செயல் நுணுக்கம்	பிரதான செயற்பாட்டு பகுதிகள்/ அமுலாக்கல் வழிகாட்டல்கள்	கால அளவு	பொறுப்பு
5.2.1 செயல் நுட்ப பிரயோகம் இலத்திரனியல் சுகாதார மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளின் தெளிவான ஏற்படுத்தல்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.	5.2.1.1 செயலாக்கம், தெளிவு, பெறுமதி விளைவு மற்றும் முன் மொழியப்பட்ட கண்டுபிடிப்புகளின் பேண் தகைமை, தன்னியக்கம் மற்றும் இலத்திரனியல் சுகாதார முறைகள் என்பவற்றை மதிப்பிடுவதற்கு தேசிய சுகாதார தகவல் வழிகாட்டல் குழுவின் (NHISC) கீழ் தேசிய மட்ட தொழில் நுட்ப குழு (WGIE) ஒன்றினை ஸ்தாபித்து செயற்படுத்துதல்.	6 மாதங்கள்	தேசிய சுகாதார தகவல் வழிகாட்டல் குழு, பணிப்பாளர்/சுகாதார தகவல்
	5.2.1.2 தொழில் நுட்பம், உட்கட்டமைப்பு, நிதி மற்றும் மனித வள கொள்திறன் என்பனவற்றின் கிடைக்கப் பெறு தன்மையினை சவனத்திற் கொண்டு படிப்படியான நடைமுறைக்கேற்ற திட்டமொன்றை விருத்தி செய்து அமுலாக்குதல்.	12 மாதங்கள்	சுகாதார சேவைகள் பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்)
	5.2.1.3 இலத்திரனியல் சுகாதார முறைகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளை வழிநடத்துவதற்கான வழிமுறைகளை ஸ்தாபித்தல்.	6 மாதங்கள்	பணிப்பாளர்/சுகாதார தகவல்
வழிகாட்டல் கொள்கை 5.3:தடையற்ற தரவு பரிமாற்ற வசதிகளுக்கு தேசிய சுகாதார தகவலின் வேறுபட்ட துணைக்கூறுகளின் பரிமாற்ற தன்மையானது தரப்படுத்துகையூடாக உறுதி செய்ய வேண்டும்.			
செயல் நுணுக்கம்	பிரதான செயற்பாட்டு பகுதிகள்/ அமுலாக்கல் வழிகாட்டல்கள்	கால அளவு	பொறுப்பு
5.3.1 தகவல் துணை முறைகளின் பரிமாற்றத் தன்மை தகவல் துணை முறைகளின் பரிமாற்றத் தன்மையினை வசதிப்படுத்தி மேம்படுத்துதல்.	5.3.1.1 தரவு துணை முறைகளுக்கிடையில் பரிமாற்றத்தினை உறுதிப்படுத்துவதற்கு தேசிய இலத்திரனியல் சுகாதார வழிகாட்டல்கள் மற்றும் தரநிலைகளில்(NeGS) குறிப்பிடப்பட்ட சுகாதார தகவல் முறைகளுக்கான கட்டட கலை மாதிரியை பின்பற்றல்.	தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள்	சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம்

செயல் நுணுக்கம்	பிரதான செயற்பாட்டு பகுதிகள்/ அமுலாக்கல் வழிகாட்டல்கள்	கால அளவு	பொறுப்பு
	5.3.1.2 அனைத்து தகவல் முறைகளது தன்னியக்கங்கள் பற்றிய வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருளிற்கான தேசிய இலத்திரனியல் சுகாதார வழிகாட்டல்கள் மற்றும் தரநிலைகளின் (NeGS)சிபாரிசு சுளிற்கான புதிய வடிவத்தைபின்பற்றுதல்.	தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள்	சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம்
	5.3.1.3 தேசிய இலத்திரனியல் சுகாதார வழிகாட்டல்கள் மற்றும் தரநிலைகளின் (NeGS) புதிய வடிவத்தில் சொற்பொருளியல் மற்றும் தொடரியல் என்பனவற்றின் புதிய வடிவத்தை பின்பற்றுதல்.	தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள்	சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம்
வழிகாட்டல் கொள்கை 5.4: சுகாதார தரவு /தகவல் இழப்பினை குறைப்பதற்கும் தரவு /தகவல் பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் சுகாதார தரவு/தகவல் களஞ்சியத்தினை வசதிப்படுத்துதல் வேண்டும்.			
செயல் நுணுக்கம்	பிரதான செயற்பாட்டு பகுதிகள்/ அமுலாக்கல் வழிகாட்டல்கள்	கால அளவு	பொறுப்பு
5.4.1 இலத்திரனியல் தரவுக் களஞ்சியம் இலத்திரனியல் தரவின் நேர்மை உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.	5.4.1.1தேசிய இலத்திரனியல் சுகாதார வழிகாட்டல்கள் மற்றும் தரநிலைகளின் (NeGS) அண்மைக் கால பதிப்பின் பிரகாரம் இலத்திரனியல் சுகாதாரத்துடன் தொடர்புபட்ட தரவு/தகவலை களஞ்சியப்படுத்தி காத்தல்.	தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள்	சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம்
	5.4.1.2 தேசிய இலத்திரனியல் சுகாதார வழிகாட்டல்கள் மற்றும் தரநிலைகளின் (NeGS) அண்மைய பதிப்பின் வழிமுறையின் பிரகாரம் முயன்று பெறப்பட்ட களஞ்சிய வசதிகளின் அனைத்து இலத்திரனியல் சுகாதாரத்துடனும் தொடர்புபட்ட தரவு/தகவலின் உடல் சார் மற்றும் மெய்நிகர் பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்துதல்.	தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள்	சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம்
வழிகாட்டல் கொள்கை 5.5: இலத்திரனியல் சுகாதாரத்துடன் தொடர்புபட்ட உட்கட்டமைப்பு மற்றும் சுகாதார வள கொள்வனவு விருத்தி என்பன வசதிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.			
இலத்திரனியல் சுகாதாரத்துடன் தொடர்புபட்ட உட்கட்டமைப்பு மற்றும் சுகாதார வள கொள்வனவு விருத்தி என்பன 1.1.2 மற்றும் 1.2.1 இல் குறிப்பிடப்பட்ட உத்திகளுடன் தொடர்புபட்டிருத்தல் வேண்டும்.			
வழிகாட்டல் கொள்கை 5.6 :தொடர்ச்சியான வருடாந்த வள ஒதுக்கீடு மற்றும் நிதி இலத்திரனியல் சுகாதார முறைகளின் பேணு தகைமைக்காக உறுதிப்படுத்தப்படல் வேண்டும்.			
இலத்திரனியல் சுகாதாரத்துடன் தொடர்புபட்ட ஒதுக்கீடு மற்றும் நிதி 1.3.1 மற்றும் 1.3.2 இல் குறிப்பிடப்பட்ட உத்திகளுடன் தொடர்புபட்டிருத்தல் வேண்டும்.			

1. சுகாதார முகாமைத்துவ தகவல் முறைமை என்பது சேகரிப்பு, கூட்டு மொத்தம், பகுப்பாய்வு, தற்போதைய சுகாதார முகாமைத்துவ தகவல்கள் என்பவற்றிக்கு உதவும் ஒரு சருவியாகும். ஒரு அரசு சுகாதார நிறுவனமொன்றில் சுகாதார முகாமைத்துவ தகவல் முறைமை செயற்பாடொன்றாக அமைச்சின் மாதாந்த சுகாதார பணிப்பாளர்கள் சந்திப்பில் செயலாற்றுகை மதிப்பீட்டிற்காக அவசியமான தகவல் குறைந்தளவிலேனும் வழங்கப்படக்கூடியதாய் இருத்தல் வேண்டும்.
2. வருடாந்த சுகாதார அறிக்கைகள் வெளியிடப்படவேண்டும் என்பதுடன் தொடர்ந்து வரும் காலாண்டின் இறுதி தருணத்தினை விடவும் தாமதிக்காத வகையில் அவை கிடைக்க கூடியதாகவும் இருக்கவேண்டும் மற்றும் சரி நுட்பம் முழுமை பொருத்தம் நிலை பேரான முழுவதுமான தர வளங்கள் நம்பகத்தன்மை பொருத்தமான முன்னிலைப்படுத்துகை மற்றும் அணுகுமுறை போன்றவற்றின் தரங்களை கொண்டிருக்கவேண்டும்.
3. சுகாதார முகாமைத்துவ தகவல் முறைமை (HMIS) என்பது சேகரிப்பு கூட்டு மொத்தம் பகுப்பாய்வு சுகாதார முகாமைத்துவ தகவலை வழங்கல் என்பவற்றிற்குரிய உதவும் ஒரு சருவியாகும். தனியார் சுகாதார நிறுவனம் ஒன்றின் சுகாதார முகாமைத்துவ தகவல் முறைமை செயற்பாடொன்றாக அமைச்சின் தனியார் சுகாதார அபிவிருத்தி பிரிவின் பணிப்பாளர் குழுமத்தினால் வழங்கப்பட்டதில் நிபந்தனை அடிப்படையிலான முக்கியத்துவமான தேவையான தகவல் குறைந்தளவிலேனும் வழங்கப்படக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும்.

02) 50% மான, தள வைத்தியசாலைகளில் மாவட்ட பொது வைத்திய சாலைகளில் மாகாண பொது வைத்தியசாலைகளில் போதனா வைத்திய சாலைகளில் சிகிச்சை பெறும் பயனாளிகளுக்கு வளம் செறிந்த தனிப்பட்ட சமுதாயத்தை அடிப்படை யாகக் கொண்ட சுகாதார தகவல் கட்டமைப்பினை பகிர்ந்தும் தொடர்ச்சியாகவும் கிடைக்கக் கூடியவாறு செய்தல்.	ஒரு தனிப்பட்ட சுகாதார பாதுகாப்பு பெறுநரை (நோயாளி) ⁴ இனங்கண்டு, சேவை வழங்குதலில் நோயாளர்பதிவு முறை செயற்பாட்டொன்றைக் கொண்டுள்ள அரச சுகாதார நிறுவனங்களின் விகிதம்	தெரிவுசெய்யப்பட்ட மொத்த சுகாதார நிறுவனங்களில் ஒரு தனிப்பட்ட சுகாதார பாதுகாப்பு பெறுநரை(நோயாளி) இனங்கண்டு சேவை வழங்குதலில் நோயாளர் பதிவு முறையில் செயற்பாடொன்றைக் கொண்டுள்ள அரச சுகாதார நிறுவனங்களின் விகிதம் ⁵ .	வருடாந்தம்	சுகாதார வசதி/ இலத்திரனியல் சுகாதார அளவீடு
	நோயாளர் தர முகாமைத்துவத்துக்கான இலத்திரனியல் வெளி நோயாளர் பிரிவு முறைமையில் செயற்பாடொன்றை கொண்டுள்ள அரச சுகாதார நிறுவனங்களின் விகிதம் ⁶	தெரிவு செய்யப்பட்ட மொத்த சுகாதார நிறுவனங்களில் நோயாளர் தர முகாமைத்துவ இலத்திரனியல் வெளிநோயாளர் பிரிவு முறைமையில் செயற்பாடொன்றை கொண்டுள்ள அரச ⁵	வருடாந்தம்	சுகாதார வசதி/ இலத்திரனியல் சுகாதார அளவீடு
	வெளிநோயாளர் பிரிவில் இலத்திரனியல் நோயாளர் பதிவு முறை செயற்பாடொன்றைக் கொண்டுள்ள அரச சுகாதார நிறுவனங்களின் விகிதம் ⁷	தெரிவு செய்யப்பட்ட மொத்த சுகாதார நிறுவனங்களில் இலத்திரனியல் நோயாளர் பதிவு முறை செயற்பாடொன்றைக் கொண்டுள்ள அரச சுகாதார நிறுவனங்களின் விகிதம்	வருடாந்தம்	சுகாதார வசதி/ இலத்திரனியல் சுகாதார அளவீடு
3. பராமரிப்பு பெறுநர்களின் இரகசியத்தன்மையைப் பேணுவதோடு, தகவல் கட்டமைப்பிற்குரிய நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றி முடியுமான அளவு தகவல்களை சுகாதார தகவல் கட்டமைப்பில் இருந்து பெறுதலும் பகிர்தலும்.	இடைமட்ட சுகாதாரத்தரவுகள் அத்துடன் முதன்மையான நோயாளர் குறியீட்டுத் தரவுகள் என்பவற்றை பங்களிப்புச் செய்யும் அரச சுகாதார நிறுவனங்களின் விகிதம் ^{8,9} .	2020 இனால் மொத்த அரச சுகாதார நிறுவனங்களில் இடைமட்ட சுகாதாரத் தரவுகள்	2020	சுகாதார வசதி/ இலத்திரனியல் சுகாதார அளவீடு

4. நோயாளர் பதிவு முறைமையின் செயற்பாடொன்றாக சுகாதாரப் பாதகாப்பு நிறுவனத்திற்கு வந்திருந்த அனைத்து நோயாளருக்கான நோயாளர் குடி விரவியல் தரவில் ஒப்படைக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட சுகாதார இலக்கம் (P.H.N) கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

5. அனைத்து ஆதார வைத்தியசாலைகள் மாவட்ட பொது வைத்தியசாலைகள் மாகாண பொது வைத்தியசாலைகள் போதுனா வைத்தியசாலைகள் போன்றவை தெரிவு செய்யப்பட்ட சுகாதார நிறுவனமாகும்

6. மருத்துவ மனையொன்றில் தங்குதல் அல்லது தொடர்ச்சியான சிகிச்சைகள் போன்றவற்றிற்கான தீர்மானத்தில் மருத்துவர் ஒருவர் அல்லது வேறு சுகாதார தொழில் வல்லுநர் போன்றவர்களினால் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு மருத்துவ அறிக்கையே விடுவித்தல் சுருக்கமொன்றாகும். நோயாளிகளின் பிரதான முறைப்பாடு இதன் சுருக்கமாக நோய் கண்டறிதல் நிர்வகிக்கப்படும் சிகிச்சை இதற்குநோயாளர்களின் பதில் வெளிப்பாடு மற்றும் விடுவித்தலில் பரிந்துரைகள் போன்றவையாகும்.

7. இலத்திரனியல் வெளி நோயாளர் பிரிவு முறைமையின் செயற்பாடொன்றானது வெளி நோயாளர் பிரிவு வெளிநோயாளர் பிரிவு சுகாதார தரவு முகாமைத்துவம் கட்டளை முறைப்பாடுகள் இலத்திரனியல் வைத்திய முறை மற்றும் மருந்தகம் போன்றவற்றிற்கு வந்த நோயாளிகளின் பதிவு குறைந்ததளவில் உள்ளடங்கும்.

8. ஒரு மத்திய நிலை சுகாதார தரவு களஞ்சியம் என்பது கணினி சோம்பில் ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட முறையில் பேணப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்ட தெரிவு செய்யப்பட்ட சுகாதார தரவின் கூட்டு மொத்தமொன்று ஒரு மத்திய இடம் ஆகும்.

9. முதன்மையான நேயாளர் குறியீடென்று சகாதாரப் பாதுகாப்பு அமைப்பொன்றில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு நேயாளர் பற்றிய தகவல் வைத்திருக்கும் ஒரு இலத்திரனியல் மருத்துவ தரவுத்தளம் ஆகும் முதன்மையான நேயாளர் குறியீடு களஞ்சியத்தில் போன்ற தகவல் நேயாளர் பெயர், பால், இனம், தங்கும் இடம், சிறாம கேசவர் பிரிவு, மின்னஞ்சல், தொலைபேசி, பதிவு செய்த நிறுவனம், பதிவேடு உருவாக்கிய திசுதி மற்றும் நேரம் அத்துடன் திருத்தம் மற்றும் வேறு உள்ளடக்கம் மற்றும் நேயாளரின் மருத்துவ வரலாற்றுக்கு தொடர்புபட்டதாக இருக்கும்.

	உள்ளக நோயாளர்களுக்கான நோயாளர் விடுவித்தல் சுரக்கங்கள் உருவாக அரசு சுகாதார நிறுவனங்களின் விகிதம், பதிவு செய்யப்பட்ட தனியார் சுகாதார நிறுவனங்களின் விகிதம்.	வகைக்குறிப்பு அத்துடன் அல்லது முதன்மையான நோயாளர் குறியீடு என்பவற்றிற்கு தரவு/ பங்களிப்பு பங்கீட்டினைச் செய்யும் தனியார் சுகாதார நிறுவனங்களின் விகிதம்.	2020	சுகாதார வசதி/ இலத்திரனியல் சுகாதார அளவீடு
	பராமரிப்பு பெறுநர்களின் ஒழுக்கத்தை கருத்திற் கொள்ளுதல் மற்றும் நம்பகத்தன்மை பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நடாத்தலில் அரசு சுகாதார நிறுவனங்களின் விகிதம்.	மொத்த அரசு சுகாதார நிறுவனங்களில் பராமரிப்புப் பெறுநர்களின் ஒழுக்கத்தைக் கருத்திற் கொள்ளுதல் மற்றும் நம்பகத் தன்மை பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடாத்தலில் அரசு சுகாதார நிறுவனங்களின் விகிதம்.	வருடாந்தம்	சுகாதார வசதி/இலத்திரனியல் சுகாதார அளவீடு
04) எல்லா தகவல் செயன்முறையின் போதும் தகவல் முறையின் ஒருங்கிணைந்து செயற்படும் தன்மையை உறுதிப்படுத்துவதோடு இலத்திரனியல் சுகாதாரம், சுகாதார தகவல் முகாமைத்துவத்தில் பொருத்தமான புதுமைகள் கண்டுபிடிப்புக்கள், மாற்றங்கள் புகுதலும் ஊக்குவித்தலும்	இலத்திரனியல் சுகாதார கண்டுபிடிப்புகளில் இலத்திரனியல் தரநிலைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்களுக்கு (NEGS) உடன்படுகின்ற அரசு சுகாதார நிறுவனங்களின் விகிதம் ¹⁰	நடைமுறை வடிவமைப்பு, வழிகாட்டுதல் அல்லது அவ்வாறான கண்டுபிடிப்புக்களின் அமுல்படுத்துகையினைக் கொண்டுள்ள மொத்த அரசு சுகாதார நிறுவனங்களின் இலத்திரனியல் சுகாதார கண்டுபிடிப்புக்களுள் இலத்திரனியல் தர நிலைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களுக்கு (NEGS) உடன்படுகின்ற அரசு சுகாதார நிறுவனங்களின் விகிதம்.	வருடாந்தம்	சுகாதார வசதி/இலத்திரனியல் சுகாதார அளவீடு
	மொத்த புள்ளிவிபரத்துக்கான பங்கு விடுவித்தல் தரவுடன் இலத்திரனியல் உள்ளக நோயுற்ற மற்றும் இறப்பு விகித அறிக்கை என்பவற்றின் அரசு சுகாதார நிறுவனங்களின் விகிதம் ¹¹ .	மொத்த அரசு சுகாதார நிறுவனங்களின் மொத்த புள்ளிவிபரத்துக்கான பங்கு விடுவித்தல் தரவுடன் இலத்திரனியல் உள்ளக நோயுற்ற மற்றும் இறப்பு விகித அறிக்கை என்பவற்றின் அரசு சுகாதார நிறுவனங்களின் விகிதம்.	வருடாந்தம்	சுகாதார வசதி/இலத்திரனியல் சுகாதார அளவீடு
05) எல்லா சுகாதார தரவுகள் தகவல்களின் பாதுகாப்பு உரிய நிலைமையை (மாறாமல் பிறவாகமல் இருக்கும் தன்மையை) உறுதிப்படுத்தல்.	சரியான இடங்களில் நிறுவனரீதியான தகவல்கள், பாதுகாப்பு செயல் நுணுக்கங்கள் அரசு சுகாதார நிறுவனங்களின் விகிதம் ¹² .	மொத்த அரசு சுகாதார நிறுவனங்களில் சரியான இடங்களில் நிறுவனரீதியான தகவல்கள், பாதுகாப்பு செயல் நுணுக்கங்கள் அரசு சுகாதார நிறுவனங்களின் விகிதம்.	வருடாந்தம்	சுகாதார வசதி/இலத்திரனியல் சுகாதார அளவீடு

10. இலத்தரனியல் சுகாதார கண்டுபிடிப்புக்களுள் புதிய விடயங்களின் அறிமுகம் அல்லது தகவல் பயன்படுத்தும் முறைகள் அல்லது சுகாதாரத்திற்கான தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது. உதாரணமாக நோயாளர் சிகிச்சையில் கண்டுபிடிப்புகள் ஆய்வுகளை நடைத்தல், சுகாதார வேலைப்படைக்கு கல்வி புகட்டல், நோயை அறிதல் மற்றும் பொது சுகாதாரத்தை கண்காணித்தல் போன்றவையாகும்.

11. இலத்திரனியல் உள்ளாக நோயுற்ற மற்றும் இறப்பு விகித அறிக்கை

12. நிறுவன ரீதியான தரவு தகவல் பாதுகாப்பு நடப்பங்களானது நம்பகத்தன்மை பாதுகாத்தல். ஒருமைப்பாடு மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க நிறுவனத்தால் அணுகப்பட்ட நிர்வகிக்கப்பட்ட மற்றும் அல்லது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சுகாதார தகவல் சொத்துக்களின் கிடைக்கக் கூடிய தன்மை என்பவற்றிற்கான சுகாதார நிறுவனத்தின் பரந்த நடப்புகள் மற்றும் பொறுப்புக்களால் நன்கு வரையறுக்கப்படும் தரவு, தகவல் முறைகள், கணினிகள், வலையமைப்பு சாதனங்கள், ஆவணங்கள் மற்றும் வாய் மொழிமூலம் தொடர்புபட்ட தகவல் போன்றவை தகவல் சொத்துக்கள் முகவரியிட்டு சேர்க்கப்படும்.

